

Monograf
**PREGNANCY DANCE
PENDEKATAN HOLISTIK
DALAM KEHAMILAN**

Wiwit Vitania
Eftyaningrum Dwi Wahyu Astutik
Yustika Rahmawati Pratami

Buku Monograf
PREGNANCY DANCE
PENDEKATAN HOLISTIK
DALAM KEHAMILAN

Bdn. Wiwit Vitania, S.ST., M.Keb.
Eftyaningrum Dwi Wahyu Astutik, M.Tr.Keb.
Yustika Rahmawati Pratami, S.Tr.Keb., M.Keb.



Buku Monograf
PREGNANCY DANCE
PENDEKATAN HOLISTIK DALAM KEHAMILAN

Bdn. Wiwit Vitania, S.ST., M.Keb.
Eftyaningrum Dwi Wahyu Astutik, M.Tr.Keb.
Yustika Rahmawati Pratami, S.Tr.Keb., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-623-89972-5-1
Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku monograf ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku yang berjudul *Pregnancy Dance: Pendekatan Holistik Dalam Kehamilan* ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat aktivitas fisik berupa tari bagi ibu hamil.

Kehamilan merupakan fase penting dalam kehidupan seorang wanita, namun sering kali disertai dengan berbagai tantangan fisik dan emosional. Masalah seperti nyeri punggung, gangguan tidur, dan depresi menjadi keluhan umum yang dapat memengaruhi kualitas hidup ibu hamil. Melalui buku ini, penulis berupaya mengkaji dan menyajikan informasi ilmiah mengenai *Pregnancy Dance* sebagai alternatif intervensi nonfarmakologis yang dapat meningkatkan kesejahteraan ibu hamil.

Penulisan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para peneliti dan praktisi kesehatan yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan data yang sangat berharga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penulisan buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya ibu hamil, tenaga kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup ibu hamil melalui pendekatan yang menyenangkan dan bermanfaat.

April, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v

BAB 1 Pendahuluan.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 Depresi Pada Ibu Hamil.....	4
--	----------

A. Pengertian Depresi pada Ibu Hamil.....	4
B. Faktor Risiko dan Penyebab Depresi Selama Kehamilan	8
C. Dampak Depresi pada Ibu Hamil.....	21
D. Pentingnya Solusi Inovatif dalam Mengatasi Depresi.....	24

BAB 3 <i>Dance Pregnancy</i> sebagai Pendekatan Terapeutik... 	27
---	-----------

A. Pengertian <i>Dance Pregnancy</i>	27
B. Sejarah dan Perkembangan <i>Dance Pregnancy</i>	28
C. Manfaat <i>Dance Pregnancy</i> bagi Kesehatan Ibu	31
D. Peran <i>Pregnancy Dance</i> dalam Mengatasi Depresi	45
E. Prinsip Dasar dan Gerakan Utama <i>Dance Pregnancy</i>	47
F. Adaptasi Gerakan untuk Ibu Hamil dengan Berbagai Kondisi	52
G. Keamanan dan Rekomendasi dalam Melakukan <i>Pregnancy Dance</i>	56
H. <i>Sequencing Dance Pregnancy</i>	58
I. <i>Peran Instruktur dan Tenaga Kesehatan</i>	60

BAB 4 Efektifitas dan Penerapan <i>Pregnancy Dance</i> dalam Kehidupan Sehari-hari	63
---	-----------

A. Pengaruh <i>Pregnancy Dance</i> terhadap Ibu Hamil.....	63
B. Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi <i>Pregnancy Dance</i>	67

C. Durasi dan Frekuensi Latihan <i>Pregnancy Dance</i>	69
D. Kombinasi <i>Pregnancy Dance</i> dengan Pola Hidup Sehat.....	72
E. Prospek <i>Pregnancy Dance</i> bagi Kesehatan Ibu Hamil	76
BAB 5 Penutup.....	78
 Daftar Pustaka	80
Glosarium	91
Profil Penulis	95



BAB 1

Pendahuluan

Kehamilan adalah fase penting dalam kehidupan seorang wanita, namun sering kali disertai dengan berbagai tantangan fisik dan emosional. Masalah seperti nyeri punggung, gangguan tidur, dan depresi menjadi keluhan umum yang dapat memengaruhi kualitas hidup ibu hamil. Menurut sebuah meta-analisis, prevalensi nyeri punggung selama kehamilan mencapai 47,8% secara global, dengan intensitas nyeri yang meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Selain itu, sekitar 62% ibu hamil mengalami gangguan tidur, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Depresi perinatal juga menjadi perhatian serius, dengan prevalensi mencapai 24,7% di berbagai negara, dan lebih tinggi di negara berkembang (Salari et al., 2023).

Beberapa pendekatan nonfarmakologis telah dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah *Pregnancy Dance*. Aktivitas ini menggabungkan gerakan tari yang dirancang khusus untuk ibu hamil dengan musik yang menenangkan, bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kesejahteraan psikologis. Penelitian oleh Vitania dan Astutik (2025) menunjukkan bahwa modifikasi gerakan tari selama kehamilan efektif dalam menurunkan tingkat depresi pada ibu hamil berisiko tinggi (Vitania & Astutik, 2025). Selain itu, studi oleh Akin dan Saydam (2020) mengungkapkan bahwa menari selama persalinan dapat

meningkatkan kepuasan ibu terhadap proses persalinan dan mengurangi rasa sakit yang dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa *Pregnancy Dance* memiliki potensi sebagai intervensi yang bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil (Akin & Saydam, 2020) .

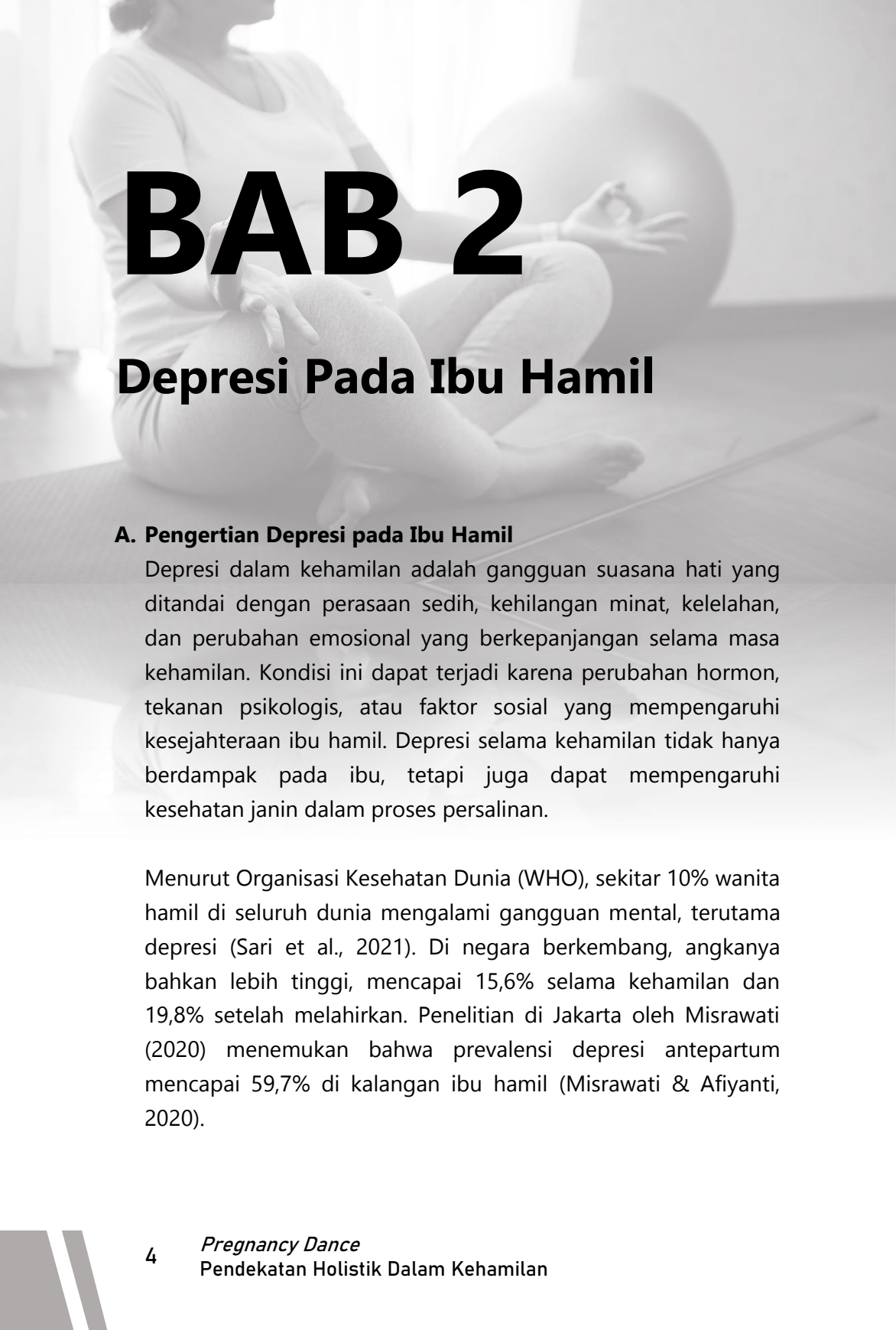
Namun, implementasi *Pregnancy Dance* dalam praktik kebidanan masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang manfaatnya, keterbatasan fasilitas yang mendukung, dan kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi efektivitas dan strategi implementasi *Pregnancy Dance* dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil. Mempertimbangkan tantangan tersebut, penting untuk mengembangkan program *Pregnancy Dance* yang dapat diakses oleh ibu hamil di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan aktivitas ini. Selain itu, edukasi kepada ibu hamil mengenai manfaat dan cara melaksanakan *Pregnancy Dance* secara aman harus menjadi bagian dari program kesehatan ibu dan anak (Zhang et al., 2025).

Adanya pendekatan yang tepat, *Pregnancy Dance* dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup ibu hamil, mengurangi risiko komplikasi, dan mendukung perkembangan janin yang sehat. Penting untuk terus melakukan penelitian dan evaluasi guna memastikan bahwa intervensi ini dapat diimplementasikan secara luas dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan ibu dan anak. Selain manfaat fisik dan psikologis, *Pregnancy Dance* juga dapat memperkuat ikatan emosional antara ibu dan janin. Gerakan tari yang lembut dan ritmis dapat merangsang respons positif dari janin, menciptakan komunikasi nonverbal yang mempererat hubungan keduanya. Hal ini sejalan dengan konsep

"bonding" prenatal", yang diyakini berkontribusi pada perkembangan emosional anak di masa depan (Toberna et al., 2020).

Di sisi lain, *Pregnancy Dance* juga dapat menjadi sarana untuk memberdayakan ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan. Dengan meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran tubuh, ibu hamil dapat merasa lebih siap dan tenang saat menghadapi tantangan persalinan. Aktivitas ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan fleksibilitas, yang bermanfaat selama proses melahirkan. Dalam konteks sosial, *Pregnancy Dance* dapat menjadi alat untuk membangun komunitas dan dukungan sosial di antara ibu hamil. Melalui kelas-kelas tari, ibu hamil dapat berbagi pengalaman, saling mendukung, dan membangun jaringan sosial yang positif. Dukungan sosial ini telah terbukti berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional selama kehamilan (Hasriani & Resmawati, 2022a; Zhu et al., 2021).

Memastikan keberhasilan implementasi *Pregnancy Dance*, penting untuk dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, instruktur tari, dan komunitas lokal. Pelatihan khusus bagi instruktur tari mengenai kebutuhan dan batasan ibu hamil, serta panduan medis yang jelas, akan memastikan bahwa aktivitas ini dilakukan dengan aman dan efektif. Integrasi *Pregnancy Dance* ke dalam program kesehatan ibu dan anak memerlukan dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai. Dengan pengakuan resmi dan dukungan dari lembaga kesehatan, *Pregnancy Dance* dapat menjadi bagian integral dari pendekatan holistik dalam perawatan kehamilan, memberikan manfaat jangka panjang bagi ibu dan anak.



BAB 2

Depresi Pada Ibu Hamil

A. Pengertian Depresi pada Ibu Hamil

Depresi dalam kehamilan adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat, kelelahan, dan perubahan emosional yang berkepanjangan selama masa kehamilan. Kondisi ini dapat terjadi karena perubahan hormon, tekanan psikologis, atau faktor sosial yang mempengaruhi kesejahteraan ibu hamil. Depresi selama kehamilan tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan janin dalam proses persalinan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 10% wanita hamil di seluruh dunia mengalami gangguan mental, terutama depresi (Sari et al., 2021). Di negara berkembang, angkanya bahkan lebih tinggi, mencapai 15,6% selama kehamilan dan 19,8% setelah melahirkan. Penelitian di Jakarta oleh Misrawati (2020) menemukan bahwa prevalensi depresi antepartum mencapai 59,7% di kalangan ibu hamil (Misrawati & Afiyanti, 2020).

Meskipun stres, kecemasan dan depresi sering dianggap serupa, ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan:

1. Stres

Stres adalah respons alami tubuh terhadap tekanan eksternal, seperti masalah keluarga, tuntutan pekerjaan, atau perubahan yang terjadi selama kehamilan. Kondisi ini biasanya bersifat sementara dan dapat mereda dengan istirahat yang cukup, dukungan sosial, serta manajemen stres yang baik. Meskipun tidak selalu berbahaya, stres yang tidak terkelola dapat menyebabkan berbagai gejala fisik dan emosional, seperti kelelahan, ketegangan otot, kesulitan berkonsentrasi, serta mudah tersinggung. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk mengenali tanda-tanda stres dan mencari cara yang tepat untuk mengatasinya guna menjaga kesejahteraan diri sendiri dan perkembangan janin ("Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum," 2023)

2. Kecemasan

Kecemasan adalah perasaan khawatir berlebihan yang berlangsung terus-menerus, sering kali tanpa penyebab yang jelas. Kondisi ini dapat mengganggu keseharian ibu hamil, menyebabkan gangguan tidur, detak jantung yang lebih cepat, serta kesulitan dalam mengendalikan pikiran negatif. Jika dibiarkan tanpa penanganan, kecemasan yang berkepanjangan dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan yang lebih serius, yang memerlukan intervensi medis atau terapi psikologis. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk mengenali tanda-tanda kecemasan dan mencari dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, atau lingkungan sekitar guna menjaga kesejahteraan mental selama kehamilan (Misrawati & Afiyanti, 2020).

3. Depresi

Depresi pada ibu hamil lebih dari sekadar stres atau kecemasan, ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Gejala ini berlangsung lebih dari dua minggu dan dapat memengaruhi fungsi ibu dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam merawat diri sendiri dan mempersiapkan kelahiran. Selain itu, depresi dapat menyebabkan gangguan nafsu makan, kelelahan ekstrem, serta perasaan putus asa yang berkepanjangan. Dalam kasus yang lebih parah, ibu hamil yang mengalami depresi berisiko memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan janinnya. Oleh karena itu, deteksi dini dan dukungan dari keluarga serta tenaga kesehatan sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih serius (Sulistyorini et al., 2023).

Tabel 2.1 Perbandingan Rinci Perbedaan Stres, Kecemasan, dan Depresi pada Ibu Hamil

Aspek	Stres	Kecemasan	Depresi
Definisi	Respon tubuh terhadap tekanan eksternal atau situasi yang menantang.	Perasaan khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang belum/tidak pasti.	Gangguan suasana hati dengan kesedihan mendalam dan hilangnya minat.
Penyebab Umum	Masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, perubahan fisik saat hamil.	Ketidakpastian seputar kehamilan, kesehatan janin, dan persalinan.	Perubahan hormon, riwayat gangguan mental, isolasi sosial, komplikasi hamil.

Durasi	Biasanya bersifat sementara.	Bisa berlangsung lama jika tidak ditangani.	Berlangsung lebih dari 2 minggu dan memengaruhi fungsi sehari-hari.
Gejala	Tegang, kelelahan, sulit tidur, mudah marah.	Gelisah, detak jantung cepat, sulit fokus, sulit tidur.	Sedih mendalam, kehilangan minat, kelelahan ekstrem, merasa tidak berguna.
Dampak pada Ibu	Menurunkan kualitas hidup jika berkepanjangan.	Menyebabkan gangguan tidur dan konsentrasi, risiko depresi.	Meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, bahkan pikiran bunuh diri.
Dampak pada Janin	Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin.	Bisa mengganggu ikatan emosional awal antara ibu dan janin.	Risiko berat badan lahir rendah, prematur, dan gangguan perkembangan janin.
Penanganan Awal	Istirahat cukup, manajemen waktu, dukungan sosial.	Relaksasi, konseling, teknik pernapasan, konsultasi psikolog.	Evaluasi medis, konseling intensif, terapi psikologis, kadang farmakoterapi.
Kapan Perlu Bantuan?	Jika berlangsung terus-menerus dan mengganggu fungsi harian.	Jika mengganggu tidur, fungsi harian, atau muncul rasa takut berlebihan.	Jika gejala menetap >2 minggu, ada pikiran menyakiti diri/janin.

Depresi pada ibu hamil dianggap berisiko tinggi jika gejalanya berlangsung lebih dari dua minggu tanpa perbaikan dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk merawat diri sendiri serta janin. Kondisi ini semakin serius jika ibu mengalami kesulitan berfungsi secara normal, kehilangan motivasi, atau bahkan muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri maupun janin (Tri Rahayu & Feriani, 2025). Risiko juga meningkat apabila ibu tidak memiliki dukungan sosial yang memadai dari pasangan, keluarga, atau lingkungan sekitar, yang dapat memperburuk perasaan kesepian dan putus asa. Selain itu, riwayat gangguan mental sebelumnya atau pengalaman depresi pascamelahirkan juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan depresi saat hamil. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi ibu hamil untuk segera mendapatkan dukungan dan penanganan yang tepat guna mencegah dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan bayi.

B. Faktor Risiko dan Penyebab Depresi Selama Kehamilan

Depresi selama kehamilan dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik dari segi biologis, psikologis, sosial, maupun medis. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan dapat memperburuk kondisi mental ibu hamil jika tidak ditangani dengan baik. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan risiko depresi selama kehamilan:

1. Perubahan Hormon Selama Kehamilan

Selama kehamilan, terjadi perubahan signifikan dalam kadar hormon yang dapat mempengaruhi suasana hati dan kesehatan mental ibu hamil. Beberapa hormon yang berpengaruh selama kehamilan:

a. Estrogen dan Progesteron

Estrogen adalah hormon yang diproduksi oleh ovarium dan plasenta selama kehamilan. Kadar estrogen meningkat

secara bertahap dan mencapai puncaknya pada trimester ketiga. Hormon ini berperan dalam membentuk pembuluh darah baru untuk menyalurkan nutrisi ke janin, meningkatkan aliran darah dalam tubuh, dan mendukung perkembangan organ janin seperti hati dan paru-paru. Namun, peningkatan kadar estrogen juga dapat memengaruhi fungsi otak yang mengatur emosi, sehingga ibu hamil mungkin mengalami perubahan suasana hati, seperti mudah marah, sedih, atau cemas (Chechko et al., 2023).

Progesteron adalah hormon yang diproduksi oleh ovarium dan plasenta, dengan kadar yang meningkat selama kehamilan. Hormon ini berfungsi menjaga otot rahim tetap rileks, mempertahankan ketebalan dinding rahim, dan menyiapkan payudara untuk produksi ASI. Selain itu, progesteron juga membantu menjaga sistem kekebalan tubuh agar tidak menyerang janin sebagai benda asing. Namun, peningkatan kadar progesteron dapat menyebabkan efek samping seperti mual, pusing, dan perubahan suasana hati (Landman et al., 2024).

Kadar estrogen dan progesteron meningkat pesat selama kehamilan. Penurunan mendadak kadar hormon ini setelah melahirkan dapat mempengaruhi neurotransmitter seperti serotonin, yang berperan dalam regulasi mood, meningkatkan risiko depresi postpartum (Rezaie-Keikhaie et al., 2020).

b. Kortisol

Kortisol adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal sebagai respons terhadap stres. Selama kehamilan, kadar kortisol secara alami meningkat untuk mendukung perkembangan janin dan mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan. Namun, peningkatan kadar kortisol yang berlebihan, terutama akibat stres kronis, dapat berdampak negatif pada kesehatan mental ibu hamil, termasuk meningkatkan risiko depresi antenatal (Tosto et al., 2023).

Beberapa studi menunjukkan bahwa ibu hamil dengan gejala depresi cenderung memiliki kadar kortisol yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil tanpa gejala depresi. Kadar kortisol yang tinggi ini dapat memengaruhi ritme sirkadian tubuh, yang berperan dalam mengatur suasana hati dan tidur. Gangguan pada ritme ini dapat memperburuk gejala depresi dan kecemasan selama kehamilan (Zacher Kjeldsen et al., 2022).

Selain itu, stres berkepanjangan selama kehamilan yang menyebabkan peningkatan kadar kortisol juga dapat memengaruhi perkembangan janin. Penelitian menunjukkan bahwa stres prenatal dapat berdampak pada perkembangan neurobehavioral anak, termasuk peningkatan risiko gangguan perilaku dan emosional di kemudian hari.

c. Hormon Gonadotropin Korionik Manusia (hCG)

Hormon hCG yang diproduksi oleh plasenta selama kehamilan dan berperan penting dalam mempertahankan kehamilan, terutama pada trimester pertama. Kadar hCG

meningkat pesat pada awal kehamilan dan mencapai puncaknya sekitar minggu ke-10, kemudian stabil hingga akhir kehamilan (Konjevod et al., 2023). Meskipun hCG tidak secara langsung menyebabkan depresi, peningkatan kadar hormon ini dapat memicu gejala fisik seperti mual dan muntah yang parah, dikenal sebagai hiperemesis gravidarum. Kondisi ini dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan emosional ibu hamil dan berkontribusi terhadap perkembangan depresi antenatal (Valdes et al., 2023).

Selain itu, perubahan hormonal selama kehamilan, termasuk peningkatan hCG, dapat memengaruhi neurotransmitter di otak yang mengatur suasana hati, seperti serotonin dan dopamin. Ketidakseimbangan neurotransmitter ini dapat menyebabkan perubahan suasana hati, kecemasan, dan gejala depresi pada beberapa wanita hamil.

Depresi perinatal merupakan kondisi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial. Perubahan hormonal yang signifikan selama kehamilan dapat memengaruhi sistem neuroendokrin, yang berkontribusi terhadap gangguan suasana hati pada ibu hamil. Selain itu, predisposisi genetik dan stres psikososial juga memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko depresi perinatal (Radoš et al., 2024). Penelitian yang dipublikasikan oleh Public Health menemukan bahwa risiko depresi pada wanita meningkat dua kali lipat selama kehamilan. Hal ini diduga akibat kombinasi perubahan hormonal dan faktor psikososial, seperti kurangnya dukungan sosial dan tekanan lingkungan (Carlson et al., 2025) .

Studi lain menunjukkan bahwa wanita hamil mengalami gejala kecemasan dan depresi yang lebih tinggi, dengan perubahan kimiawi dalam otak yang mirip dengan depresi pada saat tidak hamil. Perubahan ini dapat memengaruhi neurotransmitter yang mengatur suasana hati, seperti serotonin dan dopamin, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap depresi antepartum.

2. Faktor Sosiodemografi

a. Usia Ibu (Ibu hamil berusia ≤ 20 tahun atau ≥ 35)

Ibu hamil remaja atau kurang dari 20 tahun cenderung lebih rentan mengalami depresi perinatal dibandingkan dengan ibu hamil dewasa. Faktor-faktor seperti ketidakmatangan emosional, kurangnya pengalaman hidup, stigma sosial, dan keterbatasan dukungan sosial dapat meningkatkan risiko depresi pada kelompok ini. Sebuah studi menunjukkan bahwa ibu remaja memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk mengalami depresi pascamelahirkan dibandingkan dengan ibu dewasa. Selain itu, mereka juga lebih mungkin menghadapi tantangan seperti pengucilan sosial dan kurangnya keterlibatan pasangan dalam pengasuhan anak, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka (X. Liu et al., 2022).

Ibu hamil yang berusia 35 tahun ke atas, sering disebut sebagai usia maternal lanjut, juga menghadapi peningkatan risiko depresi selama kehamilan dan setelah melahirkan. Studi menunjukkan bahwa wanita yang melahirkan pada usia 40 hingga 44 tahun memiliki tingkat depresi pascamelahirkan sekitar tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita berusia 30 hingga 35

tahun. Faktor-faktor seperti komplikasi kehamilan, tekanan sosial, dan kekhawatiran terkait kesehatan janin dapat berkontribusi terhadap peningkatan risiko ini. Mengidentifikasi kelompok usia yang berisiko tinggi mengalami depresi perinatal penting untuk intervensi dini dan pencegahan(ACOG, 2023).

b. Status Perkawinan

Status perkawinan memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko depresi pada ibu hamil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak menikah atau mengalami ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan lebih rentan mengalami depresi selama kehamilan. Sebuah studi meta-analisis yang melibatkan 9.709 ibu hamil dari Asia dan Afrika menemukan bahwa ibu hamil yang tidak menikah memiliki risiko 2,76 kali lebih tinggi mengalami depresi antenatal dibandingkan dengan mereka yang menikah. Selain itu, kurangnya dukungan sosial juga meningkatkan risiko depresi antenatal sebesar 2,22 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa status perkawinan dan dukungan sosial merupakan faktor penting dalam kesehatan mental ibu hamil (Ediyono, 2022; X. Liu et al., 2022).

Penelitian lain menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak memiliki pasangan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan depresi dan kecemasan selama kehamilan. Studi tersebut menemukan bahwa ibu hamil tanpa pasangan memiliki kemungkinan 2,75 kali lebih besar mengalami gangguan depresi dan 3,16 kali lebih besar mengalami gangguan kecemasan dibandingkan dengan mereka yang memiliki pasangan (Bedaso et al., 2022). Selain status

perkawinan, kualitas hubungan dalam pernikahan juga berperan penting. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan yang rendah atau adanya konflik dalam hubungan dapat meningkatkan risiko distres psikologis dan depresi pada ibu hamil. Ibu hamil yang merasa tidak didukung oleh pasangannya cenderung mengalami tekanan emosional yang lebih besar, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka (Tri Rahayu & Feriani, n.d.).

Dengan demikian, status perkawinan dan kualitas hubungan dengan pasangan merupakan faktor penting yang memengaruhi kesehatan mental ibu hamil. Dukungan emosional dan sosial dari pasangan serta lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi risiko depresi selama kehamilan.

c. Tingkat Pendidikan

Ibu hamil dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi antenatal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan, kurangnya keterampilan coping, dan minimnya dukungan sosial. Sebaliknya, ibu dengan pendidikan lebih tinggi biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kehamilan, kemampuan menyelesaikan masalah yang lebih baik, dan akses yang lebih luas terhadap sumber daya kesehatan mental. Penelitian oleh Zulaiha dan Surjaningrum (2024) di Situbondo menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan risiko depresi antenatal; semakin tinggi pendidikan ibu, semakin rendah risiko depresi (Sinta et al., 2025).

Secara keseluruhan, tingkat pendidikan merupakan faktor sosiodemografi yang saling terkait dan berkontribusi terhadap risiko depresi pada ibu hamil. Peningkatan akses pendidikan dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi prevalensi depresi antenatal dan meningkatkan kesejahteraan ibu serta perkembangan janin.

d. Pendapatan dan Status Ekonomi

Pendapatan keluarga juga berperan penting dalam kesehatan mental ibu hamil. Ibu hamil dengan pendapatan rendah lebih rentan mengalami depresi antenatal dibandingkan mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan stres tambahan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Sebuah penelitian di Pekanbaru menemukan bahwa ibu hamil dengan pendapatan rendah memiliki risiko 2,7 kali lebih tinggi mengalami depresi antenatal dibandingkan mereka dengan pendapatan tinggi (Kusuma Nurin Husna & Laila, 2018).

Kondisi ekonomi keluarga berperan dalam kesejahteraan psikologis ibu hamil. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan stres tambahan terkait kebutuhan selama kehamilan dan persiapan menyambut kelahiran anak, meningkatkan risiko depresi. Pendapatan yang memadai dapat mengurangi tekanan finansial dan memberikan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik, mendukung kesehatan mental ibu hamil.

e. Tempat Tinggal

Tempat tinggal ibu hamil memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko depresi selama kehamilan. Faktor-faktor lingkungan fisik dan sosial di sekitar tempat tinggal dapat memengaruhi kesejahteraan mental ibu hamil. Sebuah studi literatur yang dilakukan oleh Universitas Pahlawan mengungkapkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan ibu dan bayi, terutama selama masa kehamilan hingga proses melahirkan. Faktor-faktor seperti sanitasi, polusi udara, dan akses terhadap layanan kesehatan di lingkungan tempat tinggal dapat berkontribusi pada hasil kehamilan yang buruk dan meningkatkan risiko depresi pada ibu hamil (Dewi Kusumawati et al., 2025).

Selain itu, penelitian oleh Silva et al. (2020) menunjukkan bahwa 45,95% faktor risiko depresi pada ibu hamil terkait dengan faktor sosial ekonomi dan kerentanan sosial. Faktor sosial ekonomi yang paling berpengaruh adalah pendapatan keluarga yang rendah dan berujung pada kesulitan ekonomi serta lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif dan tidak ideal (Sulistiyorini et al., 2023). Lebih lanjut, penelitian oleh Davoud dan Abazari (2020) di Ardabil menemukan bahwa kualitas hidup pada ibu hamil berkaitan erat dengan tempat tinggal, paritas, dan usia kehamilan. Kualitas hidup yang rendah dapat menjadi indikator adanya gangguan mental seperti depresi pada ibu hamil (Erwinda et al., 2024).

3. Faktor Psikologis dan Riwayat Kesehatan Mental

a. Riwayat Gangguan Mental

Ibu hamil dengan riwayat gangguan mental sebelumnya, seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, atau PTSD, memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi antenatal dan postnatal. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa riwayat depresi meningkatkan risiko depresi postpartum dengan odds ratio (OR) sebesar 2,7. Selain itu, depresi selama kehamilan meningkatkan risiko depresi pascapersalinan dengan OR sebesar 13,1 (Johansen et al., 2020).

Riwayat gangguan psikiatri dalam keluarga juga meningkatkan risiko depresi pada ibu hamil. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis menemukan bahwa ibu dengan riwayat keluarga gangguan psikiatri memiliki risiko hampir dua kali lipat mengalami depresi postpartum dibandingkan dengan mereka tanpa riwayat keluarga tersebut. Risiko ini tetap signifikan meskipun ibu tidak memiliki riwayat pribadi gangguan mental (Zacher Kjeldsen et al., 2022b).

b. Tingkat Stres dan Kecemasan Selama Kehamilan

Tingkat stres dan kecemasan selama kehamilan memiliki hubungan yang erat dengan kejadian depresi pada ibu hamil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stres dan kecemasan yang tidak terkelola dengan baik dapat meningkatkan risiko depresi antenatal, yang berdampak negatif pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Salah satu penelitian yang dilakukan di RB Primasari Jatiroto selama masa pandemi COVID-19 menemukan bahwa dari 43 ibu hamil yang diteliti, 51,2% mengalami stres berat dan

81,4% mengalami kecemasan sedang. Selain itu, 60,5% dari mereka mengalami depresi dalam kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa stres dan kecemasan yang tinggi selama kehamilan dapat berkontribusi signifikan terhadap munculnya depresi (Ade & Rizky, 2022).

Penelitian lain di PMB Ibu Alam Kota Salatiga menunjukkan bahwa prevalensi risiko kejadian depresi atau kecemasan dalam menghadapi persalinan pervaginam sebesar 10-25%, yang banyak terjadi pada wanita umur 20-44 tahun. Kejadian depresi atau kecemasan mempersulit proses persalinan sekitar 10-15%. Hal ini menegaskan bahwa tingkat kecemasan dan stres yang tinggi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko depresi dan komplikasi saat persalinan (Veftisia & Afriyani, 2021).

Stres dan kecemasan selama kehamilan tidak hanya berdampak pada kesehatan mental ibu, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan janin. Penelitian menunjukkan bahwa stres ibu selama kehamilan memberikan pengaruh kuat pada perkembangan janin, termasuk fungsi metabolisme, perkembangan kognitif, dan emosional. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk mengelola stres dan kecemasan dengan baik guna mencegah depresi dan memastikan kesehatan janin (De Carli et al., 2019).

c. Perubahan Citra Tubuh

Perubahan fisik selama kehamilan dapat memengaruhi citra tubuh ibu hamil, yang berkontribusi terhadap stres, kecemasan, dan depresi. Penelitian di Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Utara Jakarta Timur

menunjukkan bahwa ibu hamil dengan citra tubuh negatif lebih rentan mengalami gangguan psikologis (Erwinda et al., 2024).

4. Faktor Sosial

a. Dukungan Sosial

Dukungan sosial dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menjaga kesehatan mental ibu hamil. Kurangnya dukungan sosial dapat meningkatkan risiko depresi selama kehamilan. Penelitian oleh Yazici et al. (2018) menunjukkan bahwa dukungan sosial yang rendah selama kehamilan dan periode postpartum berhubungan dengan peningkatan gejala depresi. Dukungan sosial membantu ibu hamil beradaptasi dengan peran keibuan dan meningkatkan hubungan dengan bayi serta keluarga. Penelitian di Indonesia oleh Harnani dan Susanti (2019) menemukan bahwa 78,8% wanita yang mendapat dukungan sosial mengalami depresi postpartum, dengan korelasi erat sebesar 0,724 antara dukungan sosial keluarga dan depresi postpartum (Johansen et al., 2020; Nurhidayati et al., 2024).

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengalaman kekerasan fisik atau seksual dari pasangan merupakan faktor risiko signifikan untuk depresi selama kehamilan. Penelitian oleh Belay et al. (2019) di Ethiopia menunjukkan bahwa satu dari lima wanita hamil mengalami kekerasan oleh pasangan intim (IPV), yang secara signifikan berhubungan dengan depresi selama kehamilan. Studi ini merekomendasikan skrining untuk IPV dan depresi pada kunjungan antenatal (Belay et al., 2019). Penelitian lain di Indonesia menunjukkan bahwa wanita

hamil sering menjadi korban KDRT oleh suaminya, yang dapat berdampak pada kesehatan mental, termasuk depresi. Perlakuan kekerasan tersebut dapat berupa fisik, emosional, atau seksual (Sri, 2024).

5. Faktor Obstetrik dan Kesehatan Fisik

a. Kehamilan yang Tidak Direncanakan

Kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan telah terbukti meningkatkan risiko depresi antenatal. Sebuah meta-analisis oleh Hall et al. (2021) menemukan bahwa kehamilan yang tidak direncanakan secara signifikan meningkatkan risiko depresi selama kehamilan dan setelah melahirkan. Risiko ini lebih tinggi pada ibu yang melahirkan prematur atau belum pernah melahirkan sebelumnya (Dadi et al., 2020). Penelitian oleh Universitas Muhammadiyah Kudus menunjukkan bahwa kehamilan yang tidak direncanakan, dukungan sosial yang rendah, kekerasan dari pasangan, dan komplikasi selama persalinan meningkatkan risiko depresi pascapersalinan (Aranti, 2024).

b. Komplikasi Kehamilan

Adanya komplikasi selama kehamilan, seperti preeklamsia atau diabetes gestasional, dapat berkontribusi terhadap munculnya depresi. Penelitian oleh Musken menunjukkan bahwa gejala depresi selama kehamilan berhubungan dengan peningkatan risiko komplikasi obstetrik, termasuk hipertensi yang diinduksi kehamilan, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah (Muskens et al., 2022).

6. Faktor Gaya Hidup dan Lingkungan

a. Kualitas Tidur

Gangguan tidur atau kualitas tidur yang buruk selama kehamilan dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi. Sebuah studi prospektif oleh Thomason et al. (2024) menemukan bahwa kualitas tidur yang buruk selama kehamilan berhubungan dengan peningkatan gejala depresi (Thomason & Hendrix, 2024). Kualitas tidur yang buruk selama kehamilan berhubungan dengan peningkatan risiko depresi antenatal.

b. Paparan Stres Lingkungan

Kehidupan di lingkungan dengan tingkat stres tinggi, seperti kemiskinan atau konflik sosial, dapat mempengaruhi kesehatan mental ibu hamil. Penelitian oleh Van den Bergh et al. (2019) menunjukkan bahwa stres prenatal yang disebabkan oleh faktor psikososial, budaya, dan lingkungan dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin, serta memiliki konsekuensi jangka panjang yang dapat mempengaruhi generasi berikutnya (Van den Bergh et al., 2019). Stres yang dirasakan selama kehamilan merupakan faktor risiko penting untuk depresi prenatal, yang dapat berdampak negatif pada hasil kelahiran (Coussons-Read, 2013).

C. Dampak Depresi pada Ibu Hamil

Depresi selama kehamilan tidak hanya memengaruhi kondisi emosional ibu, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik, perkembangan janin, proses persalinan, serta hubungan ibu dengan bayi setelah lahir.

Berikut adalah beberapa dampak utama dari depresi selama kehamilan:

1. Dampak Fisik

Gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan kronis depresi dapat menyebabkan gangguan tidur, baik dalam bentuk insomnia (kesulitan tidur) maupun hipersomnia (tidur berlebihan). Ketidakseimbangan tidur ini dapat memperburuk kelelahan yang sudah umum terjadi selama kehamilan. Selain itu, perubahan nafsu makan juga sering terjadi, baik dalam bentuk kehilangan selera makan atau makan berlebihan sebagai mekanisme mengatasi stres. Kondisi ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi atau peningkatan berat badan berlebih yang berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Jika dibiarkan tanpa penanganan, ibu hamil dapat mengalami kelelahan kronis yang menghambat aktivitas sehari-hari (Institute of Mental Health, 2023).

2. Dampak Psikologis

Secara psikologis, depresi selama kehamilan dapat meningkatkan kecemasan berlebihan, bahkan terhadap hal-hal yang seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ibu hamil mungkin merasa terus-menerus khawatir tentang kehamilan, kesehatan janin, atau bahkan kemampuan dirinya sebagai seorang ibu. Selain itu, depresi juga menyebabkan hilangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, membuat ibu merasa tidak termotivasi dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, muncul perasaan bersalah yang mendalam, terutama jika ibu merasa dirinya tidak cukup baik untuk bayi yang dikandungnya, yang semakin memperburuk kondisi mentalnya (O'Dea et al., 2023).

3. Dampak terhadap Janin

Depresi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, yaitu bayi lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Selain itu, ibu yang mengalami depresi sering mengalami gangguan pola makan dan kurangnya perawatan diri, yang dapat menyebabkan janin mengalami kekurangan nutrisi dan lahir dengan berat badan rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat memengaruhi perkembangan janin, baik dari segi pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitifnya setelah lahir (Dadi et al., 2020).

4. Dampak terhadap Proses Persalinan

Ibu yang mengalami depresi selama kehamilan lebih rentan mengalami komplikasi saat persalinan, seperti tekanan darah tinggi atau persalinan yang lebih lama dan sulit. Selain itu, risiko persalinan prematur meningkat akibat gangguan hormonal dan stres yang berkepanjangan. Setelah melahirkan, ibu dengan riwayat depresi selama kehamilan juga memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami depresi pascapersalinan (*postpartum depression*), yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam merawat bayi dengan optimal (O'Dea et al., 2023).

5. Dampak terhadap Ikatan Ibu dan Bayi

Salah satu dampak jangka panjang dari depresi selama kehamilan adalah gangguan dalam hubungan ibu dan bayi setelah lahir. Ibu yang mengalami depresi mungkin kesulitan menjalin ikatan emosional dengan bayinya, baik karena perasaan tidak terhubung secara emosional maupun karena kelelahan mental dan fisik yang berkepanjangan. Kurangnya interaksi yang hangat dan penuh kasih sayang antara ibu dan bayi dapat mempengaruhi perkembangan emosional bayi,

yang berpotensi meningkatkan risiko gangguan kecemasan atau keterlambatan perkembangan sosial pada anak di masa depan (Ediyono, 2022).

Depresi selama kehamilan bukanlah kondisi yang bisa dianggap remeh karena dampaknya sangat luas, tidak hanya bagi ibu tetapi juga bagi janin, proses persalinan, serta perkembangan bayi setelah lahir. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil yang mengalami gejala depresi untuk mendapatkan dukungan sosial dan perawatan medis yang tepat guna mencegah dampak negatif yang lebih besar.

D. Pentingnya Solusi Inovatif dalam Mengatasi Depresi

Depresi selama kehamilan merupakan tantangan serius yang tidak hanya memengaruhi kesehatan mental ibu, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap perkembangan janin dan kualitas hubungan ibu dengan bayi. Pendekatan konvensional seperti farmakoterapi dan konseling psikologis memang penting, namun memiliki keterbatasan, terutama dalam hal akses, keterjangkauan, dan keberterimaan budaya. Oleh karena itu, solusi inovatif sangat dibutuhkan untuk melengkapi pendekatan medis yang ada, sekaligus memperluas jangkauan intervensi kepada ibu hamil di berbagai lapisan masyarakat (Tosto et al., 2023).

Salah satu pendekatan inovatif yang kini mulai berkembang adalah penggunaan metode terapi berbasis gerakan seperti *dance pregnancy*, yoga prenatal, hingga terapi seni. Solusi ini tidak hanya menasar aspek fisik dan emosional, tetapi juga menciptakan ruang sosial yang mendukung ibu hamil untuk terhubung dengan sesama. Intervensi berbasis aktivitas ini terbukti dapat mengurangi gejala depresi ringan hingga sedang,

memperbaiki suasana hati, dan memperkuat keterikatan ibu terhadap kehamilannya secara positif (Puji Lestari & Friscila, 2023).

Inovasi dalam penanganan depresi kehamilan juga mencakup integrasi teknologi, seperti aplikasi pemantauan mood, sesi konseling virtual, serta program berbasis komunitas yang melibatkan bidan dan tenaga kesehatan sebagai fasilitator. Pendekatan yang adaptif, fleksibel, dan kontekstual ini penting untuk memastikan setiap ibu mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan menggabungkan metode konvensional dan inovatif, kita dapat menciptakan sistem perawatan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan (Carlson et al., 2025).

Tabel 2.2 Solusi Inovatif untuk Mengatasi Depresi pada Ibu Hamil

Jenis Solusi	Contoh Aktivitas	Tujuan	Keunggulan
Terapi Berbasis Gerakan	<i>Dance Pregnancy</i> , yoga prenatal, senam hamil	Menstimulasi hormon endorfin dan meningkatkan koneksi tubuh–emosi	Meningkatkan mood, memperbaiki sirkulasi, aman dilakukan rutin
Terapi Seni dan Musik	Melukis, journaling, musik relaksasi atau menyanyi	Menyalurkan emosi dan ekspresi diri	Murah, mudah diterapkan, memperkuat identitas diri
Intervensi Digital	Aplikasi pemantauan suasana hati, meditasi terpandu, konseling daring	Mempermudah akses dukungan psikologis	Dapat dilakukan dari rumah, cocok untuk wilayah terpencil

Pendekatan Berbasis Komunitas	Kelas ibu hamil berbasis kelompok, peer support, parenting club	Meningkatkan dukungan sosial dan kebersamaan	Mencegah isolasi sosial dan memperkuat jejaring emosional
Kombinasi Psikososial dan Medis	Psikoterapi, konsultasi psikiater, konseling bidan	Memberi solusi berbasis diagnosa dan pemantauan klinis	Menyasar gejala berat dan mendalam

BAB 3

***Dance Pregnancy* sebagai Pendekatan Terapeutik**

A. Pengertian *Dance Pregnancy*

Dance Pregnancy adalah metode merujuk pada aktivitas fisik berupa gerakan tari yang dirancang khusus untuk ibu hamil. Kegiatan ini menggabungkan unsur gerakan ritmis, posisi tubuh tegak, serta perubahan posisi. Metode ini bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan kesejahteraan emosional, serta membantu ibu hamil mengatasi stres dan kecemasan selama kehamilan (Anderon-Frazier, 2020).

Sebuah tinjauan sistematis yang diterbitkan dalam *BMC Pregnancy and Childbirth* menyatakan bahwa menari selama persalinan dapat mengurangi rasa sakit, memperpendek durasi persalinan, meningkatkan kemungkinan persalinan normal, dan meningkatkan kepuasan ibu terhadap proses persalinan, tanpa efek negatif pada bayi yang baru lahir (Nga Ying Chan & Nga Ying, 2021).

Gerakan dalam *Dance Pregnancy* disesuaikan dengan kondisi tubuh ibu hamil, sehingga tetap aman dan nyaman dilakukan. Selain itu, metode ini juga memberikan manfaat psikologis

dengan meningkatkan hormon kebahagiaan seperti endorfin, serotonin, dan dopamin, yang berperan dalam mengurangi gejala depresi (Akin & Saydam, 2020).

Tidak hanya sebagai latihan fisik, *Dance Pregnancy* juga dapat menjadi sarana ekspresi diri dan interaksi sosial bagi ibu hamil. Dengan mengikuti latihan dalam kelompok, ibu hamil dapat berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, serta merasa lebih percaya diri dalam menghadapi proses kehamilan dan persalinan (Vitania & Astutik, 2025).

B. Sejarah dan Perkembangan *Dance Pregnancy*

1. Akar Budaya dan Tradisi

Dance Pregnancy adalah bentuk aktivitas fisik berbasis gerakan tari yang dirancang khusus untuk ibu hamil dengan tujuan meningkatkan kebugaran, kesejahteraan mental, serta mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru, karena dalam berbagai budaya tradisional, gerakan tubuh yang ritmis, lembut, dan berulang sudah lama digunakan oleh perempuan selama kehamilan dan menjelang persalinan sebagai bentuk ritual, penguatan tubuh, serta ekspresi emosional (Zhang et al., 2025).

Sejak zaman kuno, tarian memiliki makna spiritual dan simbolik dalam kehidupan perempuan. Di berbagai suku dan komunitas, tari digunakan sebagai bentuk persiapan fisik dan emosional dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Salah satu contohnya adalah *belly dance* (tari perut) yang berasal dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Tari ini secara historis dilakukan oleh perempuan dalam kelompok, sebagai bentuk solidaritas dan dukungan menjelang proses persalinan. Gerakan berfokus pada pinggul, perut, dan

punggung bagian bawah, yang berkontribusi dalam memperkuat otot-otot dasar panggul, meningkatkan elastisitas tubuh, serta menenangkan sistem saraf (Ami Ranita & Sri Hardjanti, 2016).

Dalam budaya Indonesia sendiri, beberapa tarian tradisional seperti Tari Golek atau gerakan dalam latihan senam hamil modern juga mengandung unsur-unsur gerakan yang lembut, berirama, dan sinkron dengan napas, yang dapat diasosiasikan dengan manfaat serupa.

2. Perkembangan Modern dan Dukungan Ilmiah

Pada era modern, dance pregnancy mulai dikembangkan secara sistematis dan berbasis ilmu kedokteran. Salah satu pelopor metode ini adalah Ann F. Cowlin, yang pada tahun 1979 mendirikan program Dancing Thru Pregnancy di Amerika Serikat. Program ini dirancang untuk membantu ibu hamil menjalani kehamilan aktif melalui kombinasi antara ilmu kebugaran, gerakan tari, dan pendidikan persiapan melahirkan.

Cowlin mengadaptasi gerakan yang aman, memperhatikan perubahan postur tubuh selama kehamilan, dan fokus pada manfaat terhadap kekuatan otot dasar panggul serta kestabilan emosional.

Penelitian internasional menunjukkan bahwa partisipasi dalam aktivitas tari selama kehamilan berdampak positif terhadap pengurangan stres, meningkatkan produksi hormon endorfin, serta membantu menjaga keseimbangan tubuh dan kontrol napas, yang penting untuk proses melahirkan (Zhang et al., 2025).

3. Implementasi di Indonesia

Di Indonesia, praktik *dance pregnancy* mulai dilirik sebagai bentuk senam alternatif yang menyenangkan dan efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Hasriani (2022) pada ibu hamil primigravida trimester III secara signifikan. Hasil penelitian tersebut mendukung pendekatan non-farmakologis dalam mengelola kesehatan mental ibu hamil, terutama dalam mengurangi ketegangan emosional dan meningkatkan rasa percaya diri (Fitriahadi et al., 2020; Hellem et al., 2020)

Penelitian lainnya dari Universitas Prima Indonesia menunjukkan bahwa *dance pregnancy* dapat membantu mengurangi risiko (pemisahan otot perut) dan memperbaiki postur tubuh ibu hamil. Hal ini sangat penting karena postur yang buruk selama kehamilan dapat menyebabkan nyeri punggung, kelelahan, serta ketidaknyamanan saat tidur dan bergerak (Fitriahadi, 2020).

4. Integrasi dengan Pendekatan Holistik

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental ibu hamil, banyak klinik kebidanan dan rumah sakit mulai mempertimbangkan integrasi *dance pregnancy* sebagai bagian dari program senam hamil. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan manfaat fisik tetapi juga membangun koneksi antara ibu dan janin melalui musik dan gerakan, serta memperkuat dukungan sosial jika dilakukan dalam kelompok (Zhang et al., 2025).

C. Manfaat *Dance Pregnancy* bagi Kesehatan Ibu

Dance Pregnancy tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan mental dan emosional ibu hamil. Dengan gerakan yang disesuaikan, latihan ini dapat membantu ibu menjalani kehamilan dengan lebih nyaman dan bahagia. Berikut adalah beberapa manfaat utama *Dance Pregnancy*.

1. Meningkatkan Kebugaran dan Kesehatan Fisik

Dance pregnancy merupakan bentuk aktivitas fisik dengan intensitas ringan hingga sedang yang dirancang khusus untuk kebutuhan ibu hamil. Gerakan yang melibatkan otot panggul, punggung, perut, dan kaki secara terarah memberikan manfaat signifikan dalam menjaga kebugaran selama kehamilan. Menurut penelitian oleh Cannon et al. (2023) dalam *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, aktivitas fisik teratur selama kehamilan, termasuk bentuk latihan seperti tarian, terbukti dapat meningkatkan tonus otot, fleksibilitas, dan keseimbangan, yang sangat penting dalam mendukung perubahan biomekanik tubuh akibat pertumbuhan janin. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa ibu hamil yang aktif secara fisik memiliki risiko lebih rendah mengalami nyeri punggung bawah (*low back pain*) (Cannon et al., 2023).

Sementara itu, dalam jurnal *Physical Therapy* menekankan bahwa latihan fisik yang ritmis, seperti gerakan tari, dapat memperkuat otot dasar panggul dan otot-otot postural, yang berperan dalam menstabilkan tulang belakang selama kehamilan. Kekuatan otot panggul yang baik akan membantu mempercepat fase pembukaan saat persalinan dan mengurangi kemungkinan komplikasi. Di tingkat nasional, penelitian oleh Situmorang (2020) menemukan bahwa latihan

fisik berbasis tarian tradisional selama kehamilan trimester kedua dan ketiga membantu mengurangi ketegangan otot dan nyeri punggung, serta meningkatkan kelenturan tubuh dan keseimbangan postural, yang semuanya penting untuk kenyamanan kehamilan dan persiapan persalinan (Situmorang et al., 2020).

2. Mengurangi Stres, Kecemasan dan Depresi

Tari, sebagai aktivitas fisik yang melibatkan gerakan tubuh secara ritmis dan harmonis, memiliki potensi besar dalam mengurangi stres dan kecemasan pada ibu hamil. Penurunan tingkat stres dan kecemasan ini sangat penting selama masa kehamilan, mengingat adanya berbagai perubahan fisik, hormon, dan emosional yang dialami oleh ibu hamil. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana tari, khususnya dalam konteks *dance pregnancy*, dapat membantu:

a. Peningkatan Produksi Hormon Kebahagiaan (Endorfin, Serotonin, Dopamin)

Tari dapat merangsang tubuh untuk memproduksi hormon-hormon positif yang dikenal sebagai endorfin, serotonin, dan dopamin — sering disebut sebagai "hormon kebahagiaan." Hormon-hormon ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan cemas atau tertekan.

1) Endorfin: Dikenal sebagai hormon yang diproduksi tubuh sebagai respons terhadap aktivitas fisik, endorfin membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan bahagia atau euforia. Ketika ibu hamil bergerak dengan ritme yang menyenangkan, tubuh akan menghasilkan lebih banyak endorfin yang membuatnya merasa lebih bahagia dan rileks (Klaperski-van der Wal et al., 2025).

- 2) Serotonin: Serotonin berperan dalam mengatur mood dan emosi. Kadar serotonin yang rendah sering kali dikaitkan dengan perasaan cemas atau depresi. Tari dapat meningkatkan kadar serotonin, yang membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan kecemasan yang sering dirasakan oleh ibu hamil (Lopez-Nieves & Jakobsche, 2022).
- 3) Dalam sistem penghargaan otak dan berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan rasa puas. Ketika ibu hamil merasakan kenikmatan atau kepuasan dari gerakan tari, dopamin akan dilepaskan, meningkatkan perasaan positif yang dapat mengurangi stress (Gönenç & Dikmen, 2020).

b. Pengaruh pada Stres Fisiologis

Selama kehamilan, perubahan hormon, seperti peningkatan kadar kortisol (hormon stres), dapat membuat ibu hamil merasa lebih cemas dan tertekan. Dance pregnancy dapat membantu mengurangi kadar kortisol dengan cara meningkatkan relaksasi tubuh secara fisik. Melalui latihan tari yang terstruktur dan ritmis, tubuh belajar untuk lebih tenang dan dapat merespons stres dengan cara yang lebih sehat (Klaperski-van der Wal et al., 2025).

c. Perbaikan Fungsi Jantung dan Peredaran Darah

Tari juga memiliki manfaat fisik yang langsung berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Gerakan yang dilakukan dalam tari membantu meningkatkan peredaran darah, menstabilkan detak jantung, dan memperbaiki sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Peningkatan aliran darah ke otak juga dapat meredakan ketegangan dan

membantu ibu hamil merasa lebih relaks, menurunkan kecemasan (Yavaş & Kirca, 2025).

3. Meningkatkan Kualitas Tidur

Gangguan tidur adalah masalah yang umum dihadapi oleh ibu hamil, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Faktor-faktor seperti perubahan hormon, ketidaknyamanan fisik, kecemasan tentang persalinan, dan peningkatan kebutuhan emosional dapat menyebabkan insomnia (kesulitan tidur) atau hipersomnia (tidur berlebihan). Salah satu cara untuk mengatasi masalah tidur ini adalah dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur dan menyenangkan, seperti *Dance Pregnancy* (Klaperski-van der Wal et al., 2025). Aktivitas ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga dapat memperbaiki kualitas tidur ibu hamil dengan cara yang alami dan terapeutik. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang bagaimana *Dance Pregnancy* dapat membantu meningkatkan kualitas tidur ibu hamil:

a. Relaksasi Otot dan Pengurangan Ketegangan Fisik

Selama kehamilan, banyak ibu hamil yang mengalami ketegangan otot, terutama pada area punggung bawah, pinggul, dan kaki, yang dapat mengganggu kenyamanan tidur. *Dance Pregnancy* memberikan gerakan yang lembut namun terkoordinasi yang membantu melemaskan otot-otot yang tegang ini. Gerakan-gerakan tersebut merangsang aliran darah, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Hasilnya, tubuh menjadi lebih rileks, yang mempermudah ibu untuk tertidur dengan lebih cepat dan tidur lebih nyenyak (Song et al., 2024).

Penelitian Gascoigne et al (2023) menemukan bahwa ibu hamil yang berpartisipasi dalam kelas dance pregnancy melaporkan penurunan yang signifikan dalam rasa sakit fisik dan ketegangan otot, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas tidur mereka (Gascoigne et al., 2023).

b. Pengaturan Pola Tidur melalui Aktivitas Fisik

Melakukan aktivitas fisik yang teratur, seperti menari, dapat membantu tubuh menyesuaikan ritme biologisnya dan meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas fisik yang dilakukan pada siang hari membantu tubuh merasa lebih lelah pada malam hari, memfasilitasi tidur yang lebih nyenyak. Dance Pregnancy juga meningkatkan sirkulasi darah, yang membantu tubuh merasa lebih segar dan siap untuk tidur setelah sesi latihan (D. Liu et al., 2025).

Penelitian Yang et al. (2020) menunjukkan bahwa ibu hamil yang terlibat dalam latihan fisik teratur, termasuk dance pregnancy, mengalami peningkatan kualitas tidur yang signifikan, berkat pengaturan ulang pola tidur yang lebih baik. Aktivitas fisik tersebut membantu meningkatkan durasi tidur dan mengurangi gangguan tidur (Yang et al., 2020).

c. Meningkatkan Pelepasan Hormon Endorfin dan Serotonin

Saat ibu hamil berpartisipasi dalam Dance Pregnancy, tubuh melepaskan hormon endorfin, serotonin, dan dopamin—hormon yang terkait dengan perasaan bahagia, relaksasi, dan kesejahteraan. Endorfin bertindak sebagai analgesik alami yang meredakan rasa sakit dan memberikan perasaan nyaman, sementara serotonin

membantu mengatur suasana hati dan tidur. Keseimbangan hormon ini tidak hanya mengurangi kecemasan dan stres tetapi juga mempermudah ibu untuk tidur dengan lebih nyenyak (Yavaş & Kırca, 2025).

Penelitian D. Liu et al. (2025) mengungkapkan bahwa gerakan fisik yang dilakukan selama dance pregnancy dapat merangsang pelepasan endorfin dan serotonin, yang berkontribusi pada penurunan kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur (D. Liu et al., 2025).

d. Mengurangi Stres dan Kecemasan yang Mengganggu Tidur

Stres dan kecemasan adalah dua faktor utama yang sering mengganggu tidur ibu hamil. Ketidakpastian tentang persalinan, kesehatan janin, atau masa depan dapat menyebabkan gelisah dan membuat ibu hamil terjaga di malam hari. Dance Pregnancy membantu mengurangi kecemasan dengan memberikan ibu hamil cara untuk mengekspresikan perasaan mereka secara positif melalui gerakan. Musik dan gerakan dalam tarian memiliki efek menenangkan, yang secara langsung mengurangi ketegangan mental dan fisik, serta mempermudah tidur yang lebih berkualitas (Lopez-Nieves & Jakobsche, 2022).

Penelitian Sun et al. (2023) dalam penelitian mereka menemukan bahwa ibu hamil yang terlibat dalam kegiatan seperti dance pregnancy melaporkan penurunan yang signifikan dalam tingkat stres dan kecemasan. Ini berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas tidur mereka (Sun et al., 2023).

e. Meningkatkan Keseimbangan Emosional dan Kesejahteraan Mental

Kualitas tidur ibu hamil juga sangat dipengaruhi oleh keadaan emosional dan mental mereka. Ibu hamil yang mengalami depresi atau kecemasan sering kali mengalami gangguan tidur, yang selanjutnya memperburuk kondisi mental mereka. Dance Pregnancy berfungsi sebagai terapi yang membantu meningkatkan keseimbangan emosional. Ketika ibu hamil merasa lebih rileks dan bahagia berkat hormon-hormon yang diproduksi selama sesi tari, hal ini membantu memperbaiki kualitas tidur mereka, yang pada gilirannya mendukung kesehatan mental secara keseluruhan (Anderon-Frazier, 2020).

Penelitian Permatasari & Dewi (2023) menyimpulkan bahwa Dance Pregnancy tidak hanya membantu ibu hamil mengurangi kecemasan dan stres, tetapi juga berperan penting dalam memperbaiki kualitas tidur mereka. Aktivitas ini meningkatkan kesejahteraan mental ibu hamil, yang mengarah pada tidur yang lebih baik dan lebih restorative (Permatasari & Dewi, 2023).

4. Meningkatkan Ikatan Ibu dan Janin

Ikatan emosional antara ibu dan janin (prenatal bonding) merupakan fondasi penting bagi perkembangan psikologis dan sosial anak setelah lahir. Ikatan ini terbentuk melalui berbagai cara, salah satunya adalah interaksi sadar antara ibu dan janin selama kehamilan. Dance Pregnancy, sebagai bentuk aktivitas fisik yang melibatkan gerakan, musik, dan kesadaran tubuh, menjadi salah satu pendekatan inovatif yang mampu memperkuat hubungan ini (Akin & Saydam,

2020). Berikut penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana Dance Pregnancy meningkatkan ikatan ibu dan janin:

a. Kesadaran Tubuh dan Koneksi Emosional

Selama sesi Dance Pregnancy, ibu hamil diajak untuk melakukan gerakan yang lembut dan mindful, yang membantu mereka lebih sadar akan tubuhnya dan sensasi dari dalam rahim. Kesadaran ini memungkinkan ibu untuk fokus pada janin, menyadari gerakan janin, dan merasakan hubungan yang lebih dalam dengannya. Dalam psikologi perinatal, "attunement" atau penyelarasan emosi ibu terhadap janin merupakan tahap penting dalam membangun ikatan awal (Morris & Saxbe, 2022). Penelitian Pino et al. (2023) menyatakan bahwa latihan yang mempromosikan kesadaran tubuh, seperti prenatal dance dan yoga, meningkatkan interaksi emosional antara ibu dan janin melalui relaksasi, fokus, dan pengurangan stres (Pino et al., 2023).

b. Stimulasi Sensorik untuk Janin

Musik dan gerakan dalam Dance Pregnancy tidak hanya bermanfaat bagi ibu, tetapi juga memberikan stimulasi sensorik kepada janin. Sejak usia kehamilan 20 minggu, janin sudah dapat merespons suara dan getaran dari luar. Musik lembut dan gerakan ritmis dalam dance pregnancy memberikan stimulus suara dan vibrasi yang menyenangkan, yang dapat memicu aktivitas otak janin dan memperkuat hubungan dengan ibunya (Branjerdporn et al., 2022). Penelitian Movalled et al. (2023) menemukan bahwa paparan musik selama kehamilan berkaitan dengan peningkatan aktivitas otak janin, dan ketika dilakukan dengan kehadiran emosional ibu (seperti dalam tarian),

hasilnya menunjukkan peningkatan koneksi neurologis dan emosional (Movalled et al., 2023).

c. Komunikasi Nonverbal Melalui Gerakan

Melalui gerakan yang disesuaikan dengan kenyamanan dan kebutuhan kehamilan, ibu dapat “berkomunikasi” dengan janinnya secara nonverbal. Saat ibu menyentuh perutnya, menggerakkan pinggul secara ritmis, atau melakukan gerakan lambat mengikuti alunan musik, ia menciptakan interaksi fisik dan emosional yang memperkuat ikatan prenatal (Lopez-Nieves & Jakobsche, 2022). Aktivitas fisik yang melibatkan kesadaran tubuh dan kontak perut, seperti dansa dan sentuhan berirama, meningkatkan komunikasi prenatal antara ibu dan janin serta berkontribusi pada pembentukan ikatan yang sehat (Movalled et al., 2023).

d. Mengurangi Hambatan Emosional dalam Membentuk Bonding

Depresi, stres, atau trauma masa lalu dapat menghalangi ibu untuk membentuk ikatan yang positif dengan janinnya. Dance Pregnancy, dengan pendekatan emosional dan terapeutiknya, membantu meredakan hambatan tersebut. Musik dan gerakan dapat membuka ruang emosional bagi ibu untuk mulai menerima dan terhubung dengan janin secara lebih dalam (Morris & Saxbe, 2022). Intervensi fisik yang berbasis gerakan ritmis, seperti prenatal dance, membantu mengurangi efek negatif stres dan kecemasan terhadap ikatan ibu-janin, serta meningkatkan perasaan kepercayaan diri dan kesiapan menjadi ibu (Branjerdporn et al., 2022).

e. Memberikan Pengalaman Positif Selama Kehamilan

Pengalaman menyenangkan dan positif selama kehamilan seperti sesi Dance Pregnancy menjadi bagian penting dari memori emosional yang dikaitkan oleh ibu terhadap janin yang dikandungnya. Perasaan bahagia, relaksasi, dan kenikmatan dalam gerakan akan dikaitkan dengan keberadaan janin, memperkuat hubungan afektif (Loukas et al., 2024). Pengalaman positif yang dialami ibu selama kehamilan memiliki dampak jangka panjang dalam memperkuat ikatan emosional dengan bayi setelah lahir, serta mengurangi risiko gangguan perkembangan emosi pada anak (Zhang et al., 2025).

5. Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Kesiapan Persalinan

Dance Pregnancy bukan sekadar aktivitas fisik ringan, tetapi merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan unsur kesadaran tubuh, relaksasi, dan gerakan terapeutik yang dirancang khusus untuk ibu hamil. Salah satu manfaat utamanya adalah membangun kepercayaan diri dan kesiapan mental-fisik ibu dalam menghadapi proses persalinan (Hasriani & Resmawati, 2022a).

Berikut penjelasan rinci berdasarkan penelitian dan teori terkini:

a. Meningkatkan Kesadaran Tubuh dan Kendali Diri

Gerakan dalam Dance Pregnancy melatih ibu untuk lebih peka terhadap sinyal tubuhnya. Melalui tarian yang terstruktur namun fleksibel, ibu diajak untuk merasakan perubahan ritme napas, ketegangan otot, dan posisi tubuh. Pemahaman ini sangat penting dalam menghadapi kontraksi, mengejan, dan beradaptasi dengan sensasi persalinan. Pendekatan gerakan berbasis kesadaran tubuh (somatic movement) membantu ibu membangun kendali

dan kepercayaan terhadap kemampuan tubuhnya dalam melahirkan (Nga Ying Chan & Nga Ying, 2021).

b. Melatih Otot dan Fleksibilitas Panggul

Gerakan tari yang lembut dan ritmis membantu melatih kelenturan serta memperkuat otot-otot inti, khususnya otot panggul, perut, dan punggung bawah bagian tubuh yang sangat penting dalam proses persalinan. Fleksibilitas panggul mempermudah penurunan kepala bayi ke jalan lahir dan membantu proses bukaan saat kontraksi. Latihan gerak teratur pada trimester kedua dan ketiga, termasuk dansa prenatal, meningkatkan fungsi otot panggul dan mempercepat fase aktif persalinan (Vitania & Astutik, 2025).

c. Membangun Kepercayaan Diri Melalui Ekspresi Diri

Dance Pregnancy memberikan ruang bagi ibu untuk mengekspresikan dirinya tanpa tekanan. Dengan iringan musik yang menyenangkan dan lingkungan yang suportif, ibu mengalami peningkatan harga diri dan keyakinan terhadap peran barunya sebagai calon ibu. Hal ini sangat penting dalam membentuk sikap positif menghadapi proses kelahiran. Program dance movement therapy prenatal selama 8 minggu secara signifikan meningkatkan self-efficacy ibu hamil dalam menghadapi persalinan (Anderon-Frazier, 2020).

d. Mengurangi Kecemasan Terkait Proses Melahirkan

Kecemasan dan ketakutan terhadap proses persalinan (tokophobia) cukup umum terjadi, terutama pada ibu primigravida. Dance Pregnancy menggabungkan teknik relaksasi dengan musik dan gerakan yang

mampu menurunkan hormon kortisol (hormon stres) dan meningkatkan hormon oksitosin yang berperan dalam kontraksi alami saat persalinan. Aktivitas fisik ringan seperti prenatal dance dapat menurunkan skor kecemasan ibu hamil dan meningkatkan kesiapan mental untuk melahirkan (Klaperski-van der Wal et al., 2025).

- e. **Simulasi Posisi dan Gerakan yang Membantu Persalinan**
Gerakan yang dilakukan dalam Dance Pregnancy seperti pelvic rocking, swaying, dan lunges tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga meniru posisi dan gerakan alami yang dianjurkan selama persalinan aktif. Ini membantu ibu merasa lebih nyaman dan mengurangi risiko intervensi medis seperti induksi atau operasi caesar. Ibu yang mengikuti kelas gerak dan kesadaran tubuh memiliki pengalaman persalinan yang lebih positif, dengan durasi persalinan aktif lebih singkat dan tingkat komplikasi lebih rendah (Akin & Saydam, 2020; Gönenc & Dikmen, 2020).
- f. **Persiapan Mental dan Emosional**
Melalui keterlibatan emosi dalam gerakan dan musik, Dance Pregnancy menciptakan ruang aman bagi ibu untuk memproses perasaan takut, khawatir, atau trauma masa lalu terkait persalinan. Pendekatan ini memberikan efek terapi emosional yang mendukung kesiapan mental ibu. Intervensi berbasis gerakan dan ekspresi diri meningkatkan kesiapan emosional dan mengurangi risiko depresi perinatal (Ami Ranita & Sri Hardjanti, 2016; Yavaş & Kırca, 2025).

6. Membangun Dukungan Sosial

Salah satu aspek penting dari kesehatan mental ibu hamil adalah dukungan sosial. Dalam konteks Dance Pregnancy, keikutsertaan dalam kelas yang melibatkan interaksi dengan ibu hamil lain tidak hanya menawarkan manfaat fisik dan emosional, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan koneksi sosial, yang terbukti memiliki efek protektif terhadap stres dan depresi selama kehamilan (Hasriani & Resmawati, 2022a). Berikut penjabaran rinci berdasarkan penelitian dan teori psikososial terkini:

a. Memfasilitasi Interaksi Sosial

Kelas Dance Pregnancy biasanya dilakukan dalam kelompok kecil dan bersifat interaktif, menciptakan suasana yang ramah dan terbuka. Ini memberikan kesempatan bagi ibu hamil untuk bertemu, berdiskusi, dan berbagi pengalaman, seperti gejala kehamilan, kekhawatiran, atau harapan mereka. Ibu hamil yang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok berbasis gerakan seperti prenatal dance atau yoga memiliki tingkat kepuasan sosial dan dukungan emosional yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak (Vitania & Astutik, 2025).

b. Mengurangi Perasaan Isolasi

Perasaan kesepian atau isolasi sosial selama kehamilan dapat memperparah stres dan meningkatkan risiko depresi antenatal. Dance Pregnancy menjadi jembatan untuk menghubungkan ibu dengan komunitas yang memiliki pengalaman serupa, sehingga mereka merasa dimengerti dan tidak sendirian. Dukungan dari kelompok sebaya secara signifikan mengurangi risiko depresi prenatal dan memperkuat ketahanan emosional ibu hamil (Anderon-Frazier, 2020).

- c. Meningkatkan Rasa Percaya Diri melalui Validasi Sosial Berbagi cerita dan mendapat tanggapan yang empatik dari ibu hamil lain dapat meningkatkan validasi diri dan percaya diri, khususnya pada ibu yang merasa ragu terhadap kemampuannya menghadapi kehamilan dan persalinan. Kelas gerakan kelompok yang bersifat suportif mendorong peningkatan self-efficacy dan motivasi dalam menjalani kehamilan sehat (Hasriani & Resmawati, 2022b).
- d. Membangun Jaringan Pendukung Jangka Panjang Relasi sosial yang terbentuk dalam kelas Dance Pregnancy dapat terus berlanjut pasca-kehamilan. Banyak ibu melaporkan bahwa teman-teman dari kelas tersebut menjadi bagian dari sistem pendukung yang berkelanjutan, baik dalam masa nifas maupun dalam mengasuh anak. Ibu yang memiliki jaringan sosial dari kelompok prenatal lebih jarang mengalami kesulitan adaptasi pada masa postpartum (Hellem et al., 2020).
- e. Meningkatkan Mood Melalui Interaksi Positif Interaksi sosial yang hangat dan positif dalam kelas Dance Pregnancy juga berkontribusi pada peningkatan mood, karena tubuh merespons hubungan sosial dengan melepaskan hormon oksitosin, serotonin, dan dopamin. Hormon-hormon ini juga memperkuat rasa nyaman dan mengurangi gejala kecemasan. Interaksi sosial dalam kelompok prenatal berperan penting dalam menjaga kestabilan emosi ibu hamil (Zhang et al., 2025).

Dengan berbagai manfaat tersebut, Dance Pregnancy menjadi salah satu solusi inovatif yang tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik ibu hamil, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan emosional dan mental selama masa kehamilan.

D. Peran *Pregnancy Dance* dalam Mengatasi Depresi

1. Sebagai Intervensi Psikoterapi Non-Farmakologis

Pregnancy Dance telah diidentifikasi sebagai intervensi non-farmakologis yang efektif dalam mengurangi gejala depresi pada ibu hamil. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisik, tetapi juga memberikan manfaat psikologis yang signifikan. Sebuah studi oleh Koch et al. (2020) menunjukkan bahwa terapi gerak tari (Dance Movement Therapy) dapat mengurangi gejala depresi melalui peningkatan regulasi emosi dan kepercayaan diri.

Selain itu, penelitian oleh ACOG (2020) menyatakan bahwa aktivitas fisik selama kehamilan, termasuk senam dan tarian, aman dan dapat menurunkan risiko gangguan mood, termasuk depresi. Lebih lanjut, penelitian oleh Li et al. (2024) menemukan bahwa tarian selama persalinan dapat meningkatkan pelepasan hormon endorfin dan serotonin, yang berkontribusi pada pengurangan stres dan peningkatan suasana hati. Dengan demikian, *Pregnancy Dance* dapat dianggap sebagai pendekatan holistik yang mendukung kesehatan mental ibu hamil melalui kombinasi gerakan, musik, dan interaksi sosial.

2. Memfasilitasi Regulasi Emosi

Tari selama kehamilan berfungsi sebagai sarana untuk mengolah emosi negatif secara fisik dan simbolis. Gerakan tubuh dan musik dalam *Pregnancy Dance* menstimulasi area otak yang mengatur emosi, seperti sistem limbik, sehingga ibu bisa lebih mudah melepaskan rasa sedih, cemas, dan tegang. Gascoigne (2023) menjelaskan bahwa "dance movement therapy" berperan dalam memproses trauma dan konflik batin secara tidak verbal, menjadikannya

efektif untuk ibu hamil yang mengalami hambatan dalam mengekspresikan emosi secara langsung (Gascoigne et al., 2023).

3. Mengaktifkan Respons Sensorimotor dan Neuroplastisitas

Tidak seperti olahraga biasa, *Pregnancy Dance* melibatkan gerakan ritmis dan afektif yang mampu mengaktifkan sistem sensorimotor otak, memperkuat koneksi antara pengalaman fisik dan emosional. Ini penting dalam proses pemulihan depresi, yang melibatkan perubahan struktur dan fungsi otak (neuroplastisitas). Penelitian oleh Lopez et al. (2022) menemukan bahwa terapi tari meningkatkan integrasi otak kanan-kiri dan keseimbangan otonom, yang secara langsung berkaitan dengan perbaikan kondisi depresi dan trauma (Lopez-Nieves & Jakobsche, 2022).

4. Sebagai Medium Kesadaran Tubuh (Body Awareness)

Ibu hamil dengan depresi sering mengalami keterputusan (disconnection) antara pikiran dan tubuh. *Pregnancy Dance* mendekatkan kembali ibu pada kesadaran tubuh melalui gerakan lembut yang terfokus. Kegiatan ini membantu ibu mengenali ketegangan, menerima perubahan fisik, dan menumbuhkan empati pada dirinya sendiri. Dalam Cochrane Review menyatakan bahwa terapi gerak berbasis tari efektif dalam meningkatkan self-awareness dan self-compassion, dua komponen penting dalam mengatasi depresi (Klaperski-van der Wal et al., 2025).

5. Mengintegrasikan Unsur Spiritualitas dan Refleksi Diri

Beberapa bentuk *Pregnancy Dance* juga menggunakan pendekatan meditatif dan spiritual, seperti gerakan slow-dance yang menyelaraskan napas, tubuh, dan perasaan. Hal

ini menciptakan ruang reflektif bagi ibu hamil untuk mengolah pengalaman kehamilan, yang dapat mengurangi tekanan psikologis dan krisis identitas selama transisi menjadi ibu. Dalam konteks budaya, mencatat bahwa integrasi dalam senam hamil tradisional memberikan efek kelegaan emosional, terutama bagi ibu hamil di trimester ketiga (Permatasari & Dewi, 2023).

E. Prinsip Dasar dan Gerakan Utama *Dance Pregnancy*

1. Prinsip Dasar *Dance Pregnancy*

a. Keselamatan dan Kenyamanan Ibu Hamil

Gerakan dalam *Dance Pregnancy* didesain aman, tidak memicu kontraksi dini, serta disesuaikan dengan trimester kehamilan. Pendekatan ini mempertimbangkan perubahan biomekanik tubuh ibu, seperti pergeseran pusat gravitasi dan peningkatan fleksibilitas sendi. Gerakan prenatal dance dengan intensitas ringan hingga sedang terbukti tidak meningkatkan risiko persalinan prematur atau fetal distress, bahkan meningkatkan kenyamanan ibu ("Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum," 2023).

b. Gerakan Terintegrasi dengan Pernapasan dan Musik

Dance Pregnancy menggabungkan gerakan ritmis dengan pola pernapasan sadar dan musik yang menenangkan. Hal ini meningkatkan koordinasi neuromotorik dan efek relaksasi. Penggunaan musik dengan tempo 60–80 bpm membantu menurunkan kadar kortisol ibu hamil dan menstabilkan mood saat melakukan prenatal dance (Mai et al., 2023).

c. Kesadaran Tubuh (Body Awareness) dan Koneksi Emosional Ibu diajak menyadari setiap gerakan tubuh dan menyelaraskan gerakan dengan perasaan terhadap janin.

Proses ini membantu membangun bonding prenatal serta mengurangi perasaan terisolasi atau cemas. Penelitian: Koch et al. (2019) (Frontiers in Psychology) menyebutkan bahwa terapi gerakan berbasis kesadaran tubuh pada ibu hamil memberikan pengaruh signifikan dalam pengurangan depresi dan peningkatan afeksi positif.

2. Gerakan Utama dalam *Dance Pregnancy*

Gerakan dalam *Dance Pregnancy* umumnya terdiri dari rangkaian low-impact movements yang dapat dimodifikasi berdasarkan usia kehamilan dan kondisi ibu. Beberapa gerakan utama antara lain (ACOG, 2023):

a. Hip Sway (Goyangan Panggul)

Gerakan menggoyangkan panggul ke kanan dan kiri secara bergantian ini bertujuan untuk melemaskan otot panggul dan mengurangi ketegangan punggung bawah. Studi oleh Gu et al. (2023) menunjukkan bahwa mobilisasi panggul seperti ini efektif dalam mengurangi nyeri persalinan dan mempercepat fase aktif persalinan, tanpa meningkatkan risiko komplikasi maternal atau fetal.

b. Side Step (Langkah Samping)

Gerakan melangkah ke samping secara bergantian ini bermanfaat untuk mengaktifkan otot kaki dan menjaga keseimbangan tubuh. Menurut rekomendasi dari American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2023), latihan seperti ini sangat direkomendasikan untuk menjaga stabilitas dan mencegah jatuh, khususnya pada trimester ketiga saat pusat gravitasi tubuh berubah.

c. Rainbow

Gerakan mengangkat kedua tangan ke atas membentuk lengkungan seperti pelangi sambil tubuh dimiringkan ke samping secara bergantian ini bertujuan untuk membuka

dada, meningkatkan fleksibilitas bahu, dan memperbaiki postur. Studi oleh Kalinowski et al. (2021) menyatakan bahwa gerakan lateral tubuh yang dikombinasikan dengan peregangan lengan dapat membantu meningkatkan kapasitas pernapasan dan mengurangi rasa sesak selama kehamilan.

d. Step Touch

Gerakan langkah kecil ke samping dengan menyentuh kaki lainnya ke sisi kaki pertama ini meningkatkan aktivitas otot paha dan menjaga keseimbangan. Sebuah tinjauan sistematis oleh Mottola et al. (2021) menyebutkan bahwa latihan ritmis ringan seperti step touch sangat efektif menjaga kesehatan jantung dan memperbaiki sirkulasi selama kehamilan.

e. Front/Back Squat

Gerakan squat dengan punggung tetap lurus ini bertujuan untuk memperkuat otot panggul, paha, dan mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan. Penelitian oleh Barakat et al. (2020) menunjukkan bahwa ibu hamil yang rutin melakukan squat memiliki durasi persalinan lebih singkat dan risiko intervensi medis yang lebih rendah.

f. Powerful Mama

Kombinasi squat ringan disertai gerakan mengangkat kedua tangan ke atas dengan ekspresi tubuh yang kuat dan afirmatif ini tidak hanya mengaktifkan otot tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kekuatan mental ibu hamil. Sebuah studi oleh Chan et al. (2021) menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang disertai afirmasi positif berpengaruh besar dalam meningkatkan self-efficacy dan mengurangi risiko depresi perinatal.

g. Baby Down

Gerakan berdiri dengan lutut sedikit ditekuk, condongkan tubuh ke depan secara perlahan sambil menopang di paha atau dinding ini membantu mengarahkan bayi turun ke panggul dengan optimal. Referensi dari Spinning Babies menjelaskan bahwa posisi ini membantu bayi masuk ke posisi optimal untuk persalinan dan mengurangi risiko malposisi janin.

h. Pelvic Tilt

Gerakan mengayunkan panggul ke depan dan belakang secara perlahan sambil mengatur napas ini melepaskan ketegangan di punggung bawah dan melatih fleksibilitas panggul. Menurut Worthington et al. (2021), pelvic tilt efektif untuk mengurangi nyeri punggung bagian bawah yang sering dialami pada trimester kedua dan ketiga.

i. Single Step

Gerakan langkah kecil ke depan atau samping dengan satu kaki, lalu kembali ke posisi awal ini melatih kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Penelitian dari Silva et al. (2022) menunjukkan bahwa latihan dengan gerakan dasar ini dapat memperbaiki refleks motorik dan mencegah kehilangan keseimbangan yang sering terjadi pada kehamilan lanjut.

j. Hip Rotation 360

Gerakan memutar panggul membentuk lingkaran penuh ini bertujuan untuk melemaskan otot panggul dan meningkatkan pelumasan sendi. Studi oleh Wang et al. (2021) menyatakan bahwa gerakan rotasi panggul secara berkala dapat memperbaiki fleksibilitas serta mengurangi tekanan sendi pada ibu hamil.

k. Single Hips Rotation

Gerakan melingkar pada satu sisi panggul secara bergantian ini melatih koordinasi otot satu sisi

tubuh. Menurut Hernando et al. (2020), latihan unilateral seperti ini penting untuk memperbaiki simetri gerak dan mencegah disfungsi simfisis pubis.

l. Arm Circle dan Shoulder Roll

Gerakan memutar lengan ke depan dan belakang, diselingi dengan menggulung bahu ke atas dan ke belakang ini meredakan ketegangan bahu, meningkatkan sirkulasi, dan memperbaiki postur. Sebuah studi oleh Choi et al. (2021) mencatat bahwa peregangan bahu secara teratur dapat menurunkan insiden nyeri leher dan bahu selama kehamilan, terutama pada ibu yang banyak beraktivitas duduk.

3. Prinsip Teknik Umum

- a. Pernafasan: Napas teratur dan dalam sangat penting selama gerakan.
- b. Keseimbangan: Lakukan gerakan dengan perlahan untuk menjaga stabilitas.
- c. Modifikasi: Jika ada keluhan seperti nyeri panggul atau punggung, gerakan dapat dimodifikasi dengan duduk atau penyangga.

Gerakan panggul selama kehamilan terbukti memberikan manfaat penting bagi kesiapan tubuh menghadapi persalinan. Satyajit et al. (2022), dalam publikasinya di *Indian Journal of Physiotherapy & Occupational Therapy*, menyatakan bahwa latihan yang melibatkan gerakan panggul mampu memperbaiki postur tubuh, memperkuat otot inti (*core muscles*), serta meningkatkan kesiapan fisik ibu untuk melahirkan. Hal ini sejalan dengan temuan Kuzik & Davies (2020), yang merekomendasikan pelatihan mobilitas panggul sebagai salah satu intervensi fisik aman bagi ibu hamil dengan

risiko rendah, guna menunjang kenyamanan dan keamanan selama masa kehamilan.

Selain manfaat fisik, gerakan dance juga berdampak positif terhadap koneksi emosional ibu dan janin. Menurut Pylvänäinen (2021) dalam *Journal of Dance Therapy*, latihan yang melibatkan gerakan tubuh bagian atas dalam tarian (*upper body dance*) mampu memperlambat keterhubungan emosional antara ibu dan janin, sehingga menciptakan kondisi psikologis yang lebih stabil dan suportif selama kehamilan.

Gerakan ritmis seperti *side-sway dance* juga terbukti membantu menurunkan tingkat stres dan tekanan darah pada ibu hamil, terutama pada trimester ketiga. Hal ini dibuktikan oleh Yang et al. (2020) yang menunjukkan bahwa tarian ringan dengan irama teratur dapat memberikan efek relaksasi yang signifikan (Yang et al., 2020).

Di sisi lain, Minghelli et al. (2020) menyebutkan bahwa kombinasi antara latihan pernapasan dan gerakan ritmis secara signifikan dapat mengoptimalkan fungsi sistem saraf parasimpatis. Aktivasi sistem ini berperan besar dalam pengelolaan kecemasan dan nyeri, menjadikan *Pregnancy Dance* sebagai salah satu pendekatan holistik yang efektif dalam mendukung kesehatan mental dan fisik ibu hamil.

F. Adaptasi Gerakan untuk Ibu Hamil dengan Berbagai Kondisi

Selama kehamilan, kondisi fisik dan medis tiap ibu sangat beragam. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan atau mengadaptasi gerakan dalam *Pregnancy Dance* agar tetap aman dan bermanfaat tanpa menimbulkan risiko. Adaptasi ini berdasarkan pertimbangan medis, trimester kehamilan, serta

kondisi fisik seperti obesitas, nyeri punggung, atau kehamilan risiko tinggi.

1. Trimester Kehamilan

Gerakan dalam *Pregnancy Dance* harus disesuaikan dengan usia kehamilan:

- a. Trimester pertama: Fokus pada gerakan ringan yang tidak terlalu membebani panggul dan sendi. Menurut Barakat et al. (2019), latihan moderat di awal kehamilan membantu adaptasi fisiologis tanpa meningkatkan risiko keguguran.
- b. Trimester kedua: Ibu hamil biasanya merasa lebih stabil. Latihan dapat mencakup *hip sways*, *side steps*, dan *pelvic tilts* dengan ritme sedang. Campos et al. (2023) menyarankan peningkatan mobilitas panggul dan latihan keseimbangan selama trimester ini.
- c. Trimester ketiga: Latihan perlu difokuskan pada relaksasi, pernapasan, dan peregangan lembut. Gerakan berdiri yang stabil seperti *step touch* dan *baby down* lebih disarankan. Pylvänäinen (2021) mencatat bahwa latihan ritmis lambat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan persalinan.

2. Kondisi Medis Khusus

- a. Obesitas: Ibu dengan obesitas memerlukan modifikasi intensitas dan durasi latihan. Menurut Minghelli et al. (2020), penggunaan gerakan berintensitas rendah seperti *hip sway* atau *upper body movement* dengan fokus pada napas dapat meningkatkan sirkulasi tanpa menekan sendi.
- b. Nyeri Punggung Bawah: Adaptasi gerakan menghindari tekanan berlebihan pada tulang belakang lumbar. Gerakan *pelvic tilts*, *gentle sway*, dan *cat-cow*

stretch dinilai efektif oleh Satyajit et al. (2022) dalam memperbaiki postur dan mengurangi nyeri punggung.

- c. Kehamilan Risiko Tinggi (misal: preeklamsia, diabetes gestasional): Latihan harus dilakukan di bawah pengawasan medis. Barakat et al. (2018) merekomendasikan *movement-based breathing exercises* yang mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, membantu relaksasi, dan menjaga tekanan darah tetap stabil.

3. Fleksibilitas dan Kekuatan Individu

Setiap ibu hamil memiliki kapasitas tubuh yang berbeda dalam hal fleksibilitas, kekuatan otot, dan mobilitas sendi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, pengalaman olahraga sebelumnya, trimester kehamilan, serta kondisi fisik dan medis yang menyertai kehamilan.

Oleh karena itu, *Pregnancy Dance* tidak menerapkan prinsip *progressive overload* seperti pada latihan fisik konvensional (yang biasanya menekankan peningkatan beban atau intensitas secara bertahap). Sebaliknya, *Pregnancy Dance* menggunakan pendekatan *self-paced* dan *intuitif*, yang berarti ibu hamil diberi keleluasaan untuk menyesuaikan intensitas dan durasi gerakan berdasarkan kenyamanan dan kemampuan tubuhnya masing-masing. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *body awareness* (kesadaran tubuh), yang sangat penting dalam menjaga keamanan latihan fisik selama kehamilan. Pylvänäinen (2021), dalam penelitiannya yang dipublikasikan di *The Arts in Psychotherapy*, menekankan bahwa peningkatan kesadaran tubuh melalui gerakan bebas seperti dalam dance therapy membantu individu mengenali batas fisik dan

emosional mereka sendiri. Dalam konteks kehamilan, hal ini tidak hanya mencegah cedera, tetapi juga memperkuat koneksi antara ibu dan janin melalui persepsi tubuh yang lebih dalam.

Selain itu, latihan yang disesuaikan dengan fleksibilitas individu dapat mencegah peregangan berlebihan, terutama karena hormon relaksin yang meningkat selama kehamilan dapat membuat sendi lebih longgar dan rentan cedera. Oleh karena itu, gerakan yang terlalu agresif atau memaksakan peregangan ekstrem sangat tidak dianjurkan.

4. Pendekatan Personal dan Inklusif

Dalam praktik *Dance for Pregnancy*, pendekatan yang personal dan inklusif menjadi salah satu prinsip penting untuk memastikan kenyamanan, keamanan, serta peningkatan partisipasi ibu hamil. Pendekatan ini menyesuaikan latihan dengan kondisi fisik, kebutuhan emosional, serta latar belakang peserta secara individual—termasuk ibu dengan kehamilan risiko tinggi, kelelahan, nyeri muskuloskeletal, atau keterbatasan gerak (Dadi et al., 2020).

Kelas kehamilan yang dirancang secara inklusif—misalnya dengan menyediakan opsi gerakan duduk, alat bantu seperti bola senam, serta pemberian jeda yang fleksibel selama Latihan berdampak langsung terhadap peningkatan partisipasi dan retensi ibu hamil. Studi tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan dengan pendekatan latihan konvensional yang cenderung seragam dan kaku, kelas yang mengakomodasi keberagaman kondisi peserta

lebih mungkin mendorong keterlibatan aktif serta membangun rasa aman dan diterima (Aranti, 2024).

Selain itu, pendekatan inklusif juga berkaitan erat dengan psikologis positif, terutama pada ibu hamil dengan riwayat trauma, kecemasan, atau depresi ringan. Dengan menciptakan ruang gerak yang ramah dan bebas penilaian, program dance pregnancy dapat berfungsi sebagai sarana ekspresi diri dan peningkatan kesejahteraan mental yang efektif. Kelas yang inklusif tidak hanya menghindari risiko fisik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan dukungan sosial, karena memungkinkan interaksi antar ibu hamil dari berbagai latar belakang secara lebih setara dan suportif.

G. Keamanan dan Rekomendasi dalam Melakukan *Pregnancy Dance*

Melakukan *Pregnancy Dance* umumnya aman untuk ibu hamil dengan kehamilan normal dan tanpa komplikasi. Namun, agar aktivitas ini benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan risiko, perlu diperhatikan aspek keamanan yang telah dibuktikan oleh sejumlah penelitian:

1. Evaluasi medis sebelum mengikuti *Pregnancy Dance*, ibu hamil disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau bidan untuk memastikan tidak ada kontraindikasi medis. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2023) menyatakan bahwa aktivitas fisik seperti menari aman dilakukan oleh ibu hamil, kecuali jika terdapat kondisi seperti perdarahan pervaginam, preeklamsia, insufisiensi serviks, atau risiko kelahiran prematur.
2. Jenis Gerakan yang Aman Gerakan dalam *Pregnancy Dance* harus:
 - a. Menghindari lompatan, rotasi ekstrem, dan gerakan mendadak.

- b. Memiliki intensitas ringan hingga sedang.
 - c. Fokus pada penguatan otot panggul, punggung, dan pernapasan. *Penelitian oleh* Koreografi gerakan lembut selama kehamilan trimester kedua dan ketiga tidak menimbulkan risiko terhadap janin dan justru meningkatkan kualitas hidup ibu hamil (Vitania & Astutik, 2025).
- 3. Pantauan denyut jantung dan kelelahan ibu hamil perlu memantau denyut jantung agar tidak melebihi 140–150 bpm (beats per minute), serta menghindari kelelahan berlebihan. Metode “talk test” (dapat berbicara selama latihan) direkomendasikan sebagai panduan praktis.
- 4. Kondisi Lingkungan dan Perlengkapan
 - a. Lakukan di tempat yang datar dan tidak licin untuk mencegah jatuh.
 - b. Gunakan pakaian dan sepatu yang nyaman.
 - c. Pastikan ventilasi ruangan baik untuk menghindari overheating (kepanasan). Keamanan aktivitas menari selama kehamilan sangat tergantung pada pemilihan ruang dan alat pendukung yang tepat.
- 5. Tanda Bahaya yang Harus Diperhatikan
Menurut WHO (2020) dan CDC, aktivitas fisik seperti *Pregnancy Dance* harus segera dihentikan jika muncul gejala seperti:
 - a. Pusing atau pingsan
 - b. Nyeri dada atau perut
 - c. Kontraksi rahim yang kuat dan teratur
 - d. Perdarahan pervaginam
 - e. Penurunan gerakan janin

H. *Sequencing Dance Pregnancy*

Sequencing Dance Pregnancy atau urutan latihan dalam *Dance Pregnancy* secara umum meliputi tiga bagian utama yang disesuaikan dengan kebutuhan fisiologis dan psikologis ibu hamil. Berikut adalah susunan lengkapnya (Anderon-Frazier, 2020; Nga Ying Chan & Nga Ying, 2021):

1. *Breathing dan Centering*

Sesi latihan *Dance Pregnancy* dimulai dengan tahap *breathing and centering*, yaitu latihan pernapasan yang dilakukan selama 3 hingga 5 menit. Ibu hamil diajak untuk melakukan pernapasan diafragma secara perlahan—menarik napas dalam melalui hidung hingga perut mengembang, lalu menghembuskannya melalui mulut secara terkontrol. Latihan ini bertujuan menenangkan pikiran, menurunkan ketegangan otot, serta meningkatkan kesadaran tubuh terhadap ritme napas. Sering kali dipadukan dengan afirmasi positif dan sentuhan lembut ke area perut, tahap ini juga membantu memperkuat ikatan emosional antara ibu dan janin. Musik yang digunakan biasanya lembut dan tanpa beat yang kuat untuk memfasilitasi ketenangan.

2. *Warming Up*

Setelah tubuh dan pikiran siap, latihan dilanjutkan dengan sesi *warming up* selama 5 hingga 8 menit. Tahap pemanasan ini bertujuan mengaktifkan otot-otot besar, meningkatkan sirkulasi darah, dan menyiapkan persendian sebelum memasuki gerakan utama. Gerakan yang dilakukan bersifat ringan dan berulang seperti *arm circle* (memutar lengan), *shoulder roll* (menggulung bahu ke belakang dan depan), serta *side step* dan *single step* untuk mengaktifkan otot kaki. Di samping itu, dilakukan pula *pelvic tilt* ringan dalam posisi berdiri guna membuka area panggul dan meningkatkan fleksibilitas. Pemanasan ini juga menjadi waktu

bagi ibu untuk mulai merasakan irama musik dan menyesuaikan napas dengan gerakan.

3. *Main Dance Sequence*

Tahap inti dari Dance Pregnancy adalah *main dance sequence* yang berlangsung selama 10 hingga 20 menit. Gerakan utama disusun secara variatif tergantung pada usia kehamilan, namun tetap menggunakan prinsip *low-impact* yang aman. Beberapa contoh gerakan yang umum digunakan antara lain *hip sway* (goyangan panggul kanan-kiri), *front/back squatting* untuk menguatkan otot paha dan panggul, *rainbow arm movement* untuk membuka dada, serta *pelvic rotation* untuk meningkatkan pelumasan sendi dan kelenturan panggul. Dalam trimester akhir, gerakan seperti *baby down position* atau *pelvic rocking* digunakan untuk membantu penurunan posisi bayi ke rongga panggul. Elemen ekspresif seperti *powerful mama move* juga dimasukkan sebagai afirmasi positif untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu menjelang persalinan.

4. *Cooling Down*

Sesi ditutup dengan tahap *cooling down* selama 5 hingga 10 menit, bertujuan mengembalikan tubuh ke keadaan tenang dan stabil. Gerakan yang digunakan dalam pendinginan bersifat lambat dan memanjang, seperti *slow step touch*, *side bend*, dan *rainbow stretch* untuk peregangan otot sisi tubuh dan bahu. Jika nyaman, ibu juga bisa melakukan posisi *butterfly sitting* (duduk dengan kedua telapak kaki saling menempel) untuk meregangkan otot pangkal paha. Proses pendinginan ditutup dengan *guided breathing* dan relaksasi ringan sambil memusatkan perhatian pada janin. Tahap ini sangat penting untuk membantu pemulihan pasca gerakan serta mencegah pusing dan kelelahan.

1. Peran Instruktur dan Tenaga Kesehatan

Instruktur dan tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan program *Pregnancy Dance*. Mereka tidak hanya memberikan instruksi yang tepat, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing yang memastikan keselamatan ibu hamil selama latihan, serta memastikan bahwa latihan tersebut membawa manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko. Peran mereka sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan adaptif bagi ibu hamil yang mengikuti program tersebut.

1. Peran Instruktur Dance

Instruktur dalam *Pregnancy Dance* bertanggung jawab untuk memimpin kelas dengan mengajarkan gerakan-gerakan yang sesuai dan aman untuk ibu hamil. Instruktur harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang anatomi tubuh ibu hamil serta perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan. Hal ini sangat penting agar instruktur dapat memberikan instruksi yang sesuai dengan kondisi tubuh ibu hamil dan menghindari gerakan-gerakan yang berisiko, seperti gerakan yang berisiko jatuh atau memberi tekanan berlebih pada panggul. Instruktur juga harus mengajarkan prinsip *body awareness*, di mana ibu hamil diajarkan untuk lebih sadar dan terhubung dengan tubuhnya. Gerakan yang diajarkan dalam *Pregnancy Dance* harus melibatkan kesadaran tubuh yang tinggi, seperti pengendalian pernapasan dan postur tubuh yang baik, yang berperan penting dalam mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan kenyamanan ibu hamil (Zhang et al., 2025).

2. Peran Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan, termasuk dokter kandungan, bidan, dan fisioterapis, memainkan peran penting dalam memastikan keamanan ibu hamil selama mengikuti *Pregnancy Dance*. Sebelum mengikuti kelas, tenaga kesehatan dapat

melakukan evaluasi medis untuk memeriksa kondisi kesehatan ibu hamil dan memberi tahu instruktur mengenai batasan-batasan fisik yang perlu dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari ACOG (2023) yang menyarankan ibu hamil untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum memulai aktivitas fisik apa pun.

3. Selain itu, tenaga kesehatan juga dapat berperan sebagai pengawas atau memberi nasihat dalam hal modifikasi gerakan. Tenaga kesehatan memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kelelahan berlebihan atau gangguan postural yang bisa berisiko bagi ibu dan janin. Jika ada kekhawatiran mengenai kondisi fisik ibu hamil, tenaga kesehatan dapat memberikan penyesuaian latihan yang lebih aman atau bahkan menyarankan penghentian sementara kelas jika diperlukan (ACOG, 2023).

4. Kolaborasi antara Instruktur dan Tenaga Kesehatan

Kerja sama yang erat antara instruktur dan tenaga kesehatan sangat penting untuk memberikan pendekatan yang holistik dalam program *Pregnancy Dance*. Dengan berbagi informasi mengenai kondisi kesehatan ibu hamil, instruktur dapat menyesuaikan gerakan atau intensitas latihan sesuai dengan rekomendasi medis. Hal ini juga membantu menciptakan pendekatan yang lebih personal dan inklusif bagi ibu hamil, seperti yang disarankan oleh Campos et al. (2023). Instruktur dapat mendiskusikan dengan tenaga kesehatan mengenai adaptasi gerakan yang sesuai jika ibu hamil memiliki kondisi tertentu, seperti nyeri punggung atau masalah pada panggul, serta bagaimana mengatur waktu dan durasi latihan agar tidak terlalu membebani ibu hamil.

5. Meningkatkan Dukungan Sosial dan Psikologis

Instruktur juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan nyaman bagi ibu hamil. *Pregnancy Dance*

bukan hanya soal gerakan fisik, tetapi juga soal dukungan emosional. Instruktur yang empatik dapat membantu ibu hamil merasa lebih percaya diri dan positif tentang tubuh mereka. Latihan yang menggabungkan gerakan ritmis dan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan mental, mengurangi kecemasan, dan memperkuat ikatan ibu dan janin (Toberna et al., 2020).

Secara keseluruhan, instruktur dan tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan keberhasilan dan keamanan program *Pregnancy Dance*. Mereka bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi ibu hamil dengan memastikan latihan aman, sesuai, dan memberikan manfaat optimal baik dari segi fisik maupun psikologis.

BAB 4

Efektifitas dan Penerapan *Pregnancy Dance* dalam Kehidupan Sehari-hari

A. Pengaruh *Pregnancy Dance* terhadap Ibu Hamil

Pregnancy Dance, atau tarian yang disesuaikan untuk ibu hamil, telah mendapatkan perhatian dalam penelitian sebagai intervensi non-farmakologis untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental selama kehamilan. Studi oleh D Liu et al. (2025) menunjukkan bahwa tarian selama persalinan dapat mengurangi rasa sakit persalinan, memperpendek durasi persalinan, mempromosikan persalinan normal, dan meningkatkan kepuasan ibu terhadap proses persalinan, tanpa efek samping negatif pada hasil neonatal.

Selain itu, penelitian oleh Sun et al., (2023) menemukan bahwa intervensi berbasis tari dapat mengurangi stres psikologis pada pasien dengan depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan interpersonal (Sun et al., 2023). Penelitian oleh Wiwit Vitania dan Eftyaningrum Dwi Wahyu Astutik (2025) menyoroti efektivitas modifikasi gerakan tari selama kehamilan dalam menurunkan tingkat depresi pada ibu

hamil berisiko tinggi. Kelompok yang mengikuti intervensi *Pregnancy Dance* mengalami penurunan skor depresi yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya melakukan latihan kehamilan biasa.

Studi oleh Gascoigne et al., (2023) menunjukkan bahwa tarian selama persalinan dapat mengurangi rasa sakit persalinan, memperpendek durasi persalinan, mempromosikan persalinan normal, dan meningkatkan kepuasan ibu terhadap proses persalinan. Meskipun demikian, implementasi *Pregnancy Dance* memerlukan perhatian terhadap beberapa faktor. Tantangan utama termasuk keterbatasan pengetahuan instruktur mengenai kehamilan berisiko tinggi dan kurangnya fasilitas yang mendukung. Solusi yang diusulkan mencakup pelatihan khusus bagi instruktur untuk memahami kondisi medis ibu hamil berisiko tinggi dan penyediaan fasilitas yang aman serta nyaman untuk latihan. Dengan pendekatan yang tepat, *Pregnancy Dance* dapat menjadi bagian integral dari program kesehatan ibu hamil berisiko tinggi (Gascoigne et al., 2023).

Secara keseluruhan, *Pregnancy Dance* menunjukkan potensi sebagai intervensi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ibu hamil, baik secara fisik maupun mental. Dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang mendalam mengenai manfaatnya, *Pregnancy Dance* dapat menjadi alternatif yang bermanfaat dalam mendukung kesehatan ibu hamil. Aktivitas fisik selama kehamilan, termasuk *Pregnancy Dance*, dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular ibu hamil. Sebuah tinjauan sistematis menunjukkan bahwa latihan fisik selama kehamilan dan periode postpartum dapat secara signifikan menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik

pada wanita hamil, yang berkontribusi pada kesehatan jantung yang lebih baik.

Partisipasi dalam aktivitas fisik seperti *Pregnancy Dance* dapat membantu mengurangi risiko diabetes gestasional. Penelitian menunjukkan bahwa wanita hamil yang aktif secara fisik memiliki risiko lebih rendah mengalami diabetes gestasional dibandingkan dengan mereka yang tidak aktif. *Pregnancy Dance* dapat berkontribusi pada keseimbangan emosional ibu hamil. Sebuah studi menunjukkan bahwa terapi gerakan tari efektif dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan (Yang et al., 2020).

Aktivitas fisik seperti menari dapat membantu meningkatkan kualitas tidur ibu hamil. Penelitian menunjukkan bahwa wanita hamil yang berpartisipasi dalam program latihan aerobik mengalami peningkatan kualitas tidur, yang penting untuk kesehatan fisik dan mental selama kehamilan. *Pregnancy Dance* dapat membantu mengurangi risiko depresi selama kehamilan. Sebuah studi menunjukkan bahwa terapi gerakan tari efektif dalam mengurangi gejala depresi pada wanita hamil, serta meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan emosional (D. Liu et al., 2025).

Partisipasi dalam kelas *Pregnancy Dance* dapat meningkatkan interaksi sosial dan dukungan emosional bagi ibu hamil. Sebuah artikel menyatakan bahwa menari selama kehamilan dapat memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, serta memberikan rasa koneksi dan kebersamaan selama kehamilan. *Pregnancy Dance* dapat membantu mengurangi risiko depresi postpartum. Sebuah studi menunjukkan bahwa terapi gerakan

tari efektif dalam mengurangi gejala depresi postpartum, serta meningkatkan kesejahteraan emosional ibu setelah melahirkan (Klaperski-van der Wal et al., 2025; Yavaş & Kirca, 2025).

Pregnancy Dance dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil secara keseluruhan. Sebuah artikel menyatakan bahwa menari selama kehamilan dapat membantu mendukung kebutuhan emosional dan fisik ibu, serta mendukung perkembangan kognitif dan emosional bayi. *Pregnancy Dance* dapat membantu mengurangi risiko depresi selama kehamilan. Sebuah studi menunjukkan bahwa terapi gerakan tari efektif dalam mengurangi gejala depresi pada wanita hamil, serta meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan emosional (Lopez-Nieves & Jakobsche, 2022).

Pregnancy Dance dapat membantu mengurangi risiko depresi selama kehamilan. Sebuah studi menunjukkan bahwa terapi gerakan tari efektif dalam mengurangi gejala depresi pada wanita hamil, serta meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan emosional. Dengan berbagai manfaat yang telah dibuktikan oleh penelitian internasional, *Pregnancy Dance* dapat menjadi bagian integral dari program kesehatan ibu hamil untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental selama kehamilan (Movalled et al., 2023).

Penting untuk memastikan bahwa instruktur *Pregnancy Dance* memiliki pelatihan yang memadai dan memahami kondisi medis ibu hamil berisiko tinggi. Dengan pendekatan yang tepat, *Pregnancy Dance* dapat menjadi alternatif yang aman dan efektif dalam mendukung kesehatan ibu hamil. Selain itu, penting untuk menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman bagi ibu hamil yang ingin berpartisipasi dalam *Pregnancy Dance*. Dengan

dukungan yang tepat, *Pregnancy Dance* dapat menjadi bagian integral dari program kesehatan ibu hamil (Boyle, 2018).

Secara keseluruhan, *Pregnancy Dance* menunjukkan potensi sebagai intervensi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ibu hamil, baik secara fisik maupun mental. Dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang mendalam mengenai manfaatnya, *Pregnancy Dance* dapat menjadi alternatif yang bermanfaat dalam mendukung kesehatan ibu hamil.

Dengan berbagai manfaat yang telah dibuktikan oleh penelitian internasional, *Pregnancy Dance* dapat menjadi bagian integral dari program kesehatan ibu hamil untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental selama kehamilan.

B. Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi *Pregnancy Dance*

Implementasi *Pregnancy Dance* sebagai bentuk aktivitas fisik untuk ibu hamil menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Studi oleh Wiwit Vitania dan Eftyaningrum Dwi Wahyu Astutik (2025) menyoroti bahwa keterbatasan pengetahuan instruktur mengenai kehamilan berisiko tinggi dan kurangnya fasilitas yang mendukung menjadi hambatan utama. Solusi yang diusulkan mencakup pelatihan khusus bagi instruktur untuk memahami kondisi medis ibu hamil berisiko tinggi dan penyediaan fasilitas yang aman serta nyaman untuk latihan.

Secara global, berbagai penelitian mengidentifikasi hambatan serupa. Studi di Afrika Selatan menemukan bahwa kelelahan, kurangnya waktu, dan ketidaknyamanan fisik menjadi alasan utama rendahnya partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik. Selain itu, kurangnya dukungan sosial dan informasi yang memadai

juga menjadi faktor penghambat. Di Iran, penelitian oleh May et al. (2024) menunjukkan bahwa ketidakpahaman tentang manfaat aktivitas fisik selama kehamilan dan kurangnya akses ke fasilitas olahraga menjadi kendala signifikan (May et al., 2024).

Dalam mengatasi tantangan ini, pendekatan yang holistik dan kontekstual diperlukan. Pendidikan kepada ibu hamil mengenai manfaat *Pregnancy Dance* dan aktivitas fisik lainnya dapat meningkatkan partisipasi. Selain itu, keterlibatan keluarga dan komunitas dalam mendukung ibu hamil untuk tetap aktif secara fisik sangat penting. Penyediaan fasilitas yang ramah ibu hamil dan pelatihan bagi instruktur untuk memahami kebutuhan khusus selama kehamilan juga menjadi langkah strategis (Kalog̃lu Binici & Aktaş, 2024).

Integrasi *Pregnancy Dance* dalam program kesehatan ibu hamil memerlukan kolaborasi antara tenaga kesehatan, instruktur kebugaran, dan pembuat kebijakan. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, tantangan dalam implementasi *Pregnancy Dance* dapat diatasi, sehingga memberikan manfaat optimal bagi kesehatan fisik dan mental ibu hamil. Untuk mendukung keberhasilan integrasi ini, penting untuk menyediakan pelatihan khusus bagi instruktur kebugaran agar mereka memahami kondisi fisiologis dan psikologis ibu hamil. Pelatihan ini dapat mencakup pengetahuan tentang perubahan hormonal selama kehamilan, teknik modifikasi gerakan tari yang aman, serta cara mengenali tanda-tanda kelelahan atau ketidaknyamanan pada peserta. Dengan demikian, instruktur dapat menyesuaikan program latihan sesuai dengan kebutuhan individu, memastikan keamanan dan kenyamanan ibu hamil selama berpartisipasi dalam *Pregnancy Dance* (Avalos et al., 2020).

Selain itu, dukungan dari pembuat kebijakan sangat penting dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai. Hal ini mencakup penyediaan ruang latihan yang aman dan nyaman, serta pengembangan panduan atau standar operasional prosedur untuk pelaksanaan *Pregnancy Dance* di berbagai fasilitas kesehatan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, program ini dapat diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu hamil di berbagai komunitas.

C. Durasi dan Frekuensi Latihan *Pregnancy Dance*

Durasi dan frekuensi *Pregnancy Dance* harus disesuaikan dengan trimester kehamilan, kondisi fisik ibu, dan tujuan latihan. Beberapa penelitian telah memberikan pedoman umum:

1. Durasi Ideal: 20–45 Menit per Sesi

Menurut Sánchez-Polán et al., (2023) dalam *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, sesi aktivitas fisik seperti *Pregnancy Dance* yang berlangsung 30 menit per hari, 3–5 kali seminggu, dianggap aman dan memberikan manfaat signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental ibu hamil.

Trimester I:

Ibu hamil disarankan untuk melakukan *Pregnancy Dance* ringan selama 20–30 menit, maksimal 3 kali seminggu, untuk mencegah kelelahan dan menjaga kestabilan hormonal

Trimester II dan III:

Frekuensi dapat ditingkatkan menjadi 3–5 kali per minggu, masing-masing berdurasi 30–45 menit. Campos et al. (2023) dalam *European Journal of Obstetrics & Gynecology* menyebutkan bahwa durasi 40 menit dengan intensitas ringan

sampai sedang membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur (Sánchez-Polán et al., 2021).

2. Jenis dan Intensitas Gerakan:

- a. Awal sesi: Pemanasan 5–10 menit (stretching lembut).
- b. Inti latihan: Gerakan utama selama 20–30 menit (misalnya *hip sway*, *step touch*, *pelvic tilt*).
- c. Akhir sesi: Pendinginan dan latihan pernapasan 5–10 menit.

3. Rekomendasi WHO (2020):

Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan ibu hamil melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik aerobik per minggu, dibagi ke dalam beberapa sesi, dan *Pregnancy Dance* merupakan salah satu bentuk aman dan menyenangkan dari aktivitas aerobik tersebut. Durasi *Pregnancy Dance* yang ideal adalah 30–45 menit per sesi, 3–5 kali per minggu, dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing ibu hamil. Latihan harus bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan jika ibu merasa lelah, pusing, atau mengalami kondisi medis tertentu.

Durasi dan frekuensi latihan *Pregnancy Dance* merupakan aspek penting dalam memastikan manfaat optimal bagi ibu hamil tanpa mengorbankan keselamatan. Berdasarkan pedoman dari American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), ibu hamil disarankan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang selama minimal 150 menit per minggu, yang dapat dibagi menjadi sesi 30 menit sebanyak lima kali seminggu. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk latihan, termasuk *Pregnancy Dance*, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu (ACOG, 2023).

Penelitian oleh Klaperski-van der Wal et al., (2025) menunjukkan bahwa tarian selama persalinan dapat mengurangi rasa sakit persalinan, memperpendek durasi persalinan, mempromosikan persalinan normal, dan meningkatkan kepuasan ibu terhadap proses persalinan. Hal ini menunjukkan bahwa *Pregnancy Dance* tidak hanya aman tetapi juga bermanfaat dalam mendukung proses persalinan (Klaperski-van der Wal et al., 2025) .

Selain itu, studi oleh Wiwit Vitania dan Eftyaningrum Dwi Wahyu Astutik (2025) menyoroti efektivitas modifikasi gerakan tari selama kehamilan dalam menurunkan tingkat depresi pada ibu hamil berisiko tinggi. Kelompok yang mengikuti intervensi *Pregnancy Dance* mengalami penurunan skor depresi yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya melakukan latihan kehamilan biasa (Vitania & Astutik, 2025).

Untuk memastikan keamanan dan efektivitas latihan, penting bagi ibu hamil untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memulai program *Pregnancy Dance*. Instruktur yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani ibu hamil dapat membantu dalam menyesuaikan gerakan dan intensitas latihan sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan pendekatan yang tepat, *Pregnancy Dance* dapat menjadi bagian integral dari program kesehatan ibu hamil, memberikan manfaat fisik dan psikologis yang signifikan (Boyle, 2022).

Secara keseluruhan, *Pregnancy Dance* yang dilakukan dengan durasi dan frekuensi yang sesuai, serta di bawah pengawasan yang tepat, dapat memberikan kontribusi positif terhadap

kesejahteraan ibu hamil. Dengan mempertimbangkan pedoman yang ada dan hasil penelitian terkini, aktivitas ini dapat menjadi pilihan yang aman dan bermanfaat dalam mendukung kesehatan selama kehamilan.

D. Kombinasi *Pregnancy Dance* dengan Pola Hidup Sehat

Menggabungkan *Pregnancy Dance* dengan pola hidup sehat selama kehamilan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan fisik dan mental ibu hamil. Aktivitas fisik seperti menari, jika dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kondisi kehamilan, dapat membantu mengurangi nyeri punggung, meningkatkan kualitas tidur, serta memperbaiki suasana hati. Studi oleh Boyle (2018) menunjukkan bahwa menari selama kehamilan dapat menjadi bentuk olahraga yang aman dan menyenangkan, yang berkontribusi pada kesejahteraan ibu hamil (Boyle, 2018).

Selain aktivitas fisik, pola makan yang seimbang dan manajemen stres juga merupakan komponen penting dari pola hidup sehat selama kehamilan. Penelitian oleh Krawczyk et al. (2023) menekankan bahwa kombinasi antara aktivitas fisik, diet yang sehat, dan manajemen stres dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan. Dengan demikian, *Pregnancy Dance* dapat menjadi bagian integral dari pendekatan holistik untuk menjaga kesehatan selama kehamilan (Pawłowski et al., 2024).

Penting untuk dicatat bahwa sebelum memulai program *Pregnancy Dance* atau perubahan pola hidup lainnya selama kehamilan, konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional sangat dianjurkan. Hal ini untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan aman dan sesuai dengan kondisi

kesehatan individu. Dengan bimbingan yang tepat, *Pregnancy Dance* dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung kehamilan yang sehat dan menyenangkan.

Mengadopsi pola hidup sehat selama kehamilan sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Berikut adalah penjabaran dari delapan aspek pola hidup sehat berdasarkan penelitian terkini (Carrizales et al., 2024; Wang et al., 2021):

1. Makan Makanan Bergizi

Selama kehamilan, ibu membutuhkan tambahan sekitar 300 kalori per hari yang sebaiknya berasal dari makanan bergizi seperti protein, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Konsumsi makanan seimbang dapat membantu mengurangi gejala kehamilan seperti mual dan sembelit.

2. Olahraga Rutin

Aktivitas fisik teratur, seperti berjalan kaki, yoga prenatal, atau senam hamil, dapat meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan mental ibu hamil. American College of Obstetricians and Gynecologists merekomendasikan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu untuk ibu hamil tanpa komplikasi medis.

3. Tidur yang Cukup

Tidur yang cukup dan berkualitas membantu pemulihan energi dan menjaga keseimbangan hormon selama kehamilan. Ibu hamil disarankan untuk tidur 7–9 jam setiap malam dan menjaga rutinitas tidur yang teratur.

4. Mengelola Stres

Stres berlebihan selama kehamilan dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, dan aktivitas fisik ringan dapat membantu mengelola stres. Studi menunjukkan bahwa

aktivitas fisik selama kehamilan dapat mengurangi risiko gangguan mood dan meningkatkan kesejahteraan emosional.

5. Kebersihan Diri dan Lingkungan

Menjaga kebersihan pribadi, seperti mencuci tangan secara teratur, mandi, dan menjaga kebersihan pakaian, penting untuk mencegah infeksi. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dapat mengurangi paparan terhadap patogen yang berpotensi membahayakan ibu dan janin.

6. Hindari Kebiasaan Buruk

Menghindari kebiasaan seperti merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan narkoba sangat penting selama kehamilan. Paparan terhadap zat-zat tersebut dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, cacat lahir, dan komplikasi lainnya.

7. Minum Air Putih Cukup

Hidrasi yang adekuat penting untuk mendukung fungsi tubuh dan volume darah yang meningkat selama kehamilan. Ibu hamil disarankan untuk minum sekitar 8 hingga 12 gelas air per hari. Air membantu pembentukan cairan ketuban, sirkulasi nutrisi, dan pembuangan limbah dari tubuh.

8. Periksa Kesehatan Rutin

Pemeriksaan prenatal secara rutin memungkinkan deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan yang mungkin timbul selama kehamilan. Konsultasi dengan dokter atau bidan membantu memantau perkembangan janin dan kesehatan ibu, serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan edukasi mengenai kehamilan yang sehat.

Pola makan yang sehat juga memainkan peran penting dalam kesehatan mental selama kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa wanita hamil dengan depresi prenatal memiliki risiko lebih

tinggi terhadap kualitas diet yang buruk dibandingkan dengan wanita tanpa depresi prenatal. Kualitas diet yang buruk, seperti konsumsi tinggi kalori kosong dan rendahnya asupan sayuran dan buah, dapat memperburuk gejala depresi. Oleh karena itu, mengadopsi pola makan seimbang yang kaya akan nutrisi penting dapat membantu mengurangi risiko depresi selama kehamilan (Avalos et al., 2020).

Selain itu, manajemen stres yang efektif selama kehamilan sangat penting untuk mencegah depresi. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, dan aktivitas fisik ringan dapat membantu mengelola stres. Studi menunjukkan bahwa aktivitas fisik selama kehamilan dapat mengurangi risiko gangguan mood dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Integrasi *Pregnancy Dance* dengan teknik relaksasi ini dapat memberikan manfaat tambahan dalam mengurangi stres dan mencegah depresi (May et al., 2024).

Tidur yang cukup dan berkualitas juga merupakan komponen penting dalam menjaga kesehatan mental selama kehamilan. Gangguan tidur dapat memperburuk gejala depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, menjaga rutinitas tidur yang teratur dan memastikan waktu tidur yang cukup setiap malam dapat membantu mengurangi risiko depresi selama kehamilan (Cannon et al., 2023).

Secara keseluruhan, kombinasi *Pregnancy Dance* dengan pola hidup sehat termasuk pola makan bergizi, manajemen stres, dan tidur yang cukup dapat secara signifikan mengurangi risiko depresi selama kehamilan. Pendekatan holistik ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental ibu hamil tetapi juga memberikan manfaat bagi perkembangan janin dan hasil

kehamilan yang lebih baik. Konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan individu sangat dianjurkan.

E. Prospek *Pregnancy Dance* bagi Kesehatan Ibu Hamil

Pregnancy Dance telah menunjukkan prospek yang menjanjikan dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas menari selama kehamilan dapat membantu mengurangi nyeri punggung, meningkatkan kualitas tidur, serta memperbaiki suasana hati. Studi oleh Boyle (2018) menekankan bahwa menari selama kehamilan dapat menjadi bentuk olahraga yang aman dan menyenangkan, yang berkontribusi pada kesejahteraan ibu hamil (Boyle, 2018).

Selain manfaat fisik, *Pregnancy Dance* juga berkontribusi pada kesejahteraan mental ibu hamil. Aktivitas ini dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan selama kehamilan, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kontrol diri. Penelitian oleh Akin dan Saydam (2020) menunjukkan bahwa menari selama persalinan dapat meningkatkan kepuasan ibu terhadap proses persalinan dan mengurangi rasa sakit yang dirasakan (Kalog̃lu Binici & Aktaş, 2024).

Lebih lanjut, *Pregnancy Dance* juga dapat meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan bayi. Melalui gerakan yang ritmis dan musik yang menyenangkan, ibu dapat merasakan kedekatan emosional dengan bayi yang dikandungnya. Hal ini dapat membantu membangun ikatan yang kuat antara ibu dan bayi sejak dalam kandungan. Studi oleh Dance (Boyle) 2018 menekankan bahwa menari selama kehamilan dapat membantu

ibu mengelola gejala kecemasan dan depresi pascapersalinan, serta memperkuat koneksi antara ibu dan bayi (Boyle, 2018).

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, *Pregnancy Dance* memiliki prospek yang cerah sebagai bagian dari program kesehatan ibu hamil. Namun, penting untuk memastikan bahwa aktivitas ini dilakukan dengan aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional sebelum memulai program *Pregnancy Dance* sangat dianjurkan untuk memastikan keamanan dan efektivitas latihan.



BAB 5

Penutup

Pregnancy Dance telah terbukti memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan ibu hamil, baik secara fisik maupun psikologis. Aktivitas ini dapat membantu mengurangi nyeri punggung, meningkatkan kualitas tidur, serta memperbaiki suasana hati. Studi oleh Boyle (2020) menunjukkan bahwa menari selama kehamilan dapat menjadi bentuk olahraga yang aman dan menyenangkan, yang berkontribusi pada kesejahteraan ibu hamil.

Selain manfaat fisik, *Pregnancy Dance* juga berkontribusi pada kesejahteraan mental ibu hamil. Aktivitas ini dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan selama kehamilan, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kontrol diri. Penelitian oleh Vitania dan Astutik (2025) menyoroti efektivitas modifikasi gerakan tari selama kehamilan dalam menurunkan tingkat depresi pada ibu hamil berisiko tinggi.

Lebih lanjut, *Pregnancy Dance* juga dapat meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan bayi. Melalui gerakan yang ritmis dan musik yang menyenangkan, ibu dapat merasakan kedekatan emosional dengan bayi yang dikandungnya. Hal ini dapat membantu membangun ikatan yang kuat antara ibu dan bayi sejak

dalam kandungan. Studi oleh Dance Kalog (2024) menekankan bahwa menari selama kehamilan dapat membantu ibu mengelola gejala kecemasan dan depresi pascapersalinan, serta memperkuat koneksi antara ibu dan bayi.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, *Pregnancy Dance* memiliki prospek yang cerah sebagai bagian dari program kesehatan ibu hamil. Namun, penting untuk memastikan bahwa aktivitas ini dilakukan dengan aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional sebelum memulai program *Pregnancy Dance* sangat dianjurkan untuk memastikan keamanan dan efektivitas latihan.

Daftar Pustaka

- ACOG. (2023). Screening and Diagnosis of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum. *Obstetrics & Gynecology*, 141(6), 1232–1261. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000005200>
- Ade, W. P., & Rizky, W. (2022). *Tingkat Kecemasan, Stres dan Depresi pada Ibu Hamil Selama Masa Pandemi Covid-19 di RB Primasari Jatiroto*.
- Akin, B., & Saydam, B. K. (2020). The effect of labor dance on perceived labor pain, birth satisfaction, and neonatal outcomes. *EXPLORE*, 16(5), 310–317. <https://doi.org/10.1016/j.explore.2020.05.017>
- Ami Ranita, B., & Sri Hardjanti, T. (2016). Pengaruh Belly Dance Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Di BPM Ranting 3 Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 1(3), 26–34.
- Anderon-Frazier, B. (2020). *The Integration of a Dance/Movement Therapy Practice for The Integration of a Dance/Movement Therapy Practice for Midwifery and Pregnant Women*. https://digitalcommons.lesley.edu/expressive_theses/292
- Aranti, W. A. (2024). Associations between Unplanned Pregnancy, Low Social Support, Domestic Violence, and Intrapartum Complication, with Postpartum Depression: Meta Analysis. *Journal of Maternal and Child Health*, 9(2), 169–185. <https://doi.org/10.26911/thejmch.2024.09.02.05>
- Avalos, L. A., Caan, B., Nance, N., Zhu, Y., Li, D.-K., Quesenberry, C., Hyde, R. J., & Hedderson, M. M. (2020). Prenatal Depression and Diet Quality During Pregnancy. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 120(6), 972–984. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.12.011>

- Bedaso, A., Adams, J., Peng, W., Xu, F., & Sibbritt, D. (2022). An examination of the association between marital status and prenatal mental disorders using linked health administrative data. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 735. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-05045-8>
- Belay, S., Astatkie, A., Emmelin, M., & Hinderaker, S. G. (2019). Intimate partner violence and maternal depression during pregnancy: A community-based cross-sectional study in Ethiopia. *PLOS ONE*, 14(7), e0220003. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220003>
- Boyle, T. (2018). *Dancing While Pregnant: Benefits and How to do it Safely*. <https://dc.etsu.edu/honors/717>
- Boyle, T. (2022). *Dancing While Pregnant: Benefits and How to do it Safely*. <https://dc.etsu.edu/honors/717>
- Branjerdporn, G., Meredith, P., Wilson, T., & Strong, J. (2022). Infant Developmental Outcomes: Influence of Prenatal Maternal–Fetal Attachment, Adult Attachment, Maternal Well-Being, and Perinatal Loss. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4), 2433. <https://doi.org/10.3390/ijerph19042433>
- Cannon, S. S., Lastella, M., Evenson, K. R., & Hayman, M. J. (2023). The association between physical activity and sleep during pregnancy: a systematic review. *Behavioral Sleep Medicine*, 21(4), 513–528. <https://doi.org/10.1080/15402002.2022.2124258>
- Carlson, K., Mughal, S., Azhar, Y., & Siddiqui, W. (2025). *Perinatal Depression*.
- Carrizales, L. M., Vilca, L. W., Santiago-Vizcarra, C., Fernández, Y. S., & Caycho-Rodríguez, T. (2024). Impact of healthy lifestyles on mental health indicators in adolescents after the COVID-19 pandemic. *Mental Health & Prevention*, 36, 200371. <https://doi.org/10.1016/j.mhp.2024.200371>

- Chechko, N., Stickel, S., & Votinov, M. (2023). Neural responses to monetary incentives in postpartum women affected by baby blues. *Psychoneuroendocrinology*, 148, 105991. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2022.105991>
- Coussons-Read, M. E. (2013). Effects of prenatal stress on pregnancy and human development: mechanisms and pathways. *Obstetric Medicine*, 6(2), 52–57. <https://doi.org/10.1177/1753495x12473751>
- Dadi, A. F., Miller, E. R., Bisetegn, T. A., & Mwanri, L. (2020). Global burden of antenatal depression and its association with adverse birth outcomes: An umbrella review. *BMC Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-8293-9>
- De Carli, P., Costantini, I., Sessa, P., Visentin, S., Pearson, R. M., & Simonelli, A. (2019). The expectant social mind: A systematic review of face processing during pregnancy and the effect of depression and anxiety. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 102, 153–171. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.04.013>
- Dewi Kusumawati, P., Deivita, Y., Winarningsih, R. A., Naya, P. A., Permatananda, K., & Maidelwita, Y. (2025). Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi Saat Melahirkan. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1193–1204.
- Ediyono, S. (2022). Faktor Risiko dan Dampak Terjadinya Depresi Antenatal. In *Jurnal Indonesia Kebidanan* (Vol. 6).
- Erwinda, D., Dwi Guna, S., Studi Ilmu Keperawatan, P., Keperawatan, F., Riau, U., Pekanbaru, K., & Riau, P. (2024). Hubungan Ketidaknyamanan Fisik dan Psikologis terhadap Kualitas Hidup Ibu Hamil. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health E-ISSN*, 3(1), 300–313.
- Fitriahadi, E. (2020). Dance Pregnancy Berpengaruh Menurunkan Diastasis Recti pada Ibu Hamil. *Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.31764/mj.v5i1.1075>

- Fitriahadi, E., Sri Daryanti, M., & Artikel, R. (2020). Dance Pregnancy Berpengaruh menurunkan Doastasis Recti Pada Ibu Hamil Di BPM Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Midwifery Journal / Kebidanan*, 5(1), 45–51.
- Gascoigne, E. L., Webster, C. M., Honart, A. W., Wang, P., Smith-Ryan, A., & Manuck, T. A. (2023). Physical activity and pregnancy outcomes: an expert review. *American Journal of Obstetrics & Gynecology* MFM, 5(1), 100758. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2022.100758>
- Gönenç, İ. M., & Dikmen, H. A. (2020). Effects of Dance and Music on Pain and Fear During Childbirth. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 49(2), 144–153. <https://doi.org/10.1016/j.jogn.2019.12.005>
- Hasriani, S., & Resmawati, R. (2022a). Pengaruh Aerobic Dance Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Solo. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 2(2), 255–260. <https://doi.org/10.54082/jupin.71>
- Hasriani, S., & Resmawati, R. (2022b). Pengaruh Aerobic Dance Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Solo. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 2(2), 255–260. <https://doi.org/10.54082/jupin.71>
- Hellem, T., Sung, Y.-H., Ferguson, H., & Hildreth, L. (2020). The emotional dance with depression: A longitudinal investigation of OULA® for depression in women. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 24(4), 413–422. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.05.007>
- Institute of Mental Health, N. (2023). *Perinatal Depression*.
- Johansen, S. L., Stenhaug, B. A., Robakis, T. K., Williams, K. E., & Cullen, M. R. (2020). Past Psychiatric Conditions as Risk Factors for Postpartum Depression. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 81(1). <https://doi.org/10.4088/JCP.19m12929>
- Kaloglı Binici, D., & Aktaş, S. (2024). The Effect of Labor Dance in the First Stage of Labor on Labor Pain, Anxiety, Duration of

- Labor, and Maternal Satisfaction with Labor: A Randomized Controlled Study. *Journal of Integrative and Complementary Medicine*, 30(4), 383–393. <https://doi.org/10.1089/jicm.2022.0818>
- Klaperski-van der Wal, S., Skinner, J., Opacka-Juffry, J., & Pfeffer, K. (2025). Dance and stress regulation: A multidisciplinary narrative review. *Psychology of Sport and Exercise*, 78, 102823. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2025.102823>
- Konjevod, M., Gredicak, M., Vuic, B., Tudor, L., Nikolac Perkovic, M., Milos, T., Svob Strac, D., Pivac, N., & Nedic Erjavec, G. (2023). Overview of metabolomic aspects in postpartum depression. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 127, 110836. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2023.110836>
- Kusuma Nurin Husna, R., & Laila, A. (2018). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Depresi Antenatal Pada Ibu Hamil Di Bidan Praktik Mandiri (BPM) Kota Pekanbaru Tahun 2017. In *Jurnal Ibu dan Anak* (Vol. 6, Issue 1).
- Landman, A., Ngameni, E. G., Dubreucq, M., Dubreucq, J., Tebeka, S., & Dubertret, C. (2024). Postpartum blues: a predictor of postpartum depression, from the IGEDEPP Cohort. *European Psychiatry*, 67(1), e30. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2024.1741>
- Liu, D., Liu, K., Xie, L., He, M., & Liu, X. (2025). The effect of physical activity on sleep disorders in pregnant people: a meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-024-07129-z>
- Liu, X., Wang, S., & Wang, G. (2022). Prevalence and Risk Factors of Postpartum Depression in Women: A Systematic Review and Meta-analysis. *Journal of Clinical Nursing*, 31(19–20), 2665–2677. <https://doi.org/10.1111/jocn.16121>
- Lopez-Nieves, I., & Jakobsche, C. E. (2022). Biomolecular Effects of Dance and Dance/Movement Therapy: A Review. *American*

- Journal of Dance Therapy*, 44(2), 241–263.
<https://doi.org/10.1007/s10465-022-09368-z>
- Loukas, S., Filippa, M., de Almeida, J. S., Boehringer, A. S., Tolsa, C. B., Barcos-Munoz, F., Grandjean, D. M., van de Ville, D., & Hüppi, P. S. (2024). Newborn's neural representation of instrumental and vocal music as revealed by fMRI: A dynamic effective brain connectivity study. *Human Brain Mapping*, 45(10).
<https://doi.org/10.1002/hbm.26724>
- Mai, S., Liu, Y., He, H., & Yan, X. (2023). The Effects of Different Exercise Programs on the Prevention of Perinatal Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology*, 50(1).
<https://doi.org/10.31083/j.ceog5001009>
- May, L. E., Moss, S. J., Szumilewicz, A., Santos-Rocha, R., & Shojaeian, N. A. (2024). Barriers and Facilitators of Physical Activity in Pregnancy and Postpartum Among Iranian Women: A Scoping Review. *Healthcare*, 12(23), 2416.
<https://doi.org/10.3390/healthcare12232416>
- Misrawati, & Afiyanti, Y. (2020). Antenatal depression and its associated factors among pregnant women in Jakarta, Indonesia. *Enfermería Clínica*, 30, 96–101.
<https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.07.020>
- Morris, A. R., & Saxbe, D. E. (2022). Mental Health and Prenatal Bonding in Pregnant Women During the COVID-19 Pandemic: Evidence for Heightened Risk Compared With a Prepandemic Sample. *Clinical Psychological Science*, 10(5), 846–855.
<https://doi.org/10.1177/21677026211049430>
- Movalled, K., Sani, A., Nikniaz, L., & Ghofazadeh, M. (2023). The impact of sound stimulations during pregnancy on fetal learning: a systematic review. *BMC Pediatrics*, 23(1).
<https://doi.org/10.1186/s12887-023-03990-7>
- Muskens, L., Boekhorst, M. G. B. M., Kop, W. J., van den Heuvel, M. I., Pop, V. J. M., & Beerthuisen, A. (2022). The association of

- unplanned pregnancy with perinatal depression: a longitudinal cohort study. *Archives of Women's Mental Health*, 25(3), 611–620. <https://doi.org/10.1007/s00737-022-01225-9>
- Nga Ying Chan, A., & Nga Ying, A. (2021). *The Implementation of Mindfulness and Dance/Movement Therapy For Women with Postpartum Depression: A Literature Review*. https://digitalcommons.lesley.edu/expressive_theses/384
- Nurhidayati, E., Dwiarini, M., & Imamah, N. F. (2024). Social Support among Mothers with Spouse Postpartum Depression. *International Journal of Nursing and Health Services (IJNHS)*, 7(1), 395–403. <https://doi.org/10.35654/ijnhs.v7i1.769>
- O'Dea, G. A., Youssef, G. J., Hagg, L. J., Francis, L. M., Spry, E. A., Rossen, L., Smith, I., Teague, S. J., Mansour, K., Booth, A., Davies, S., Hutchinson, D., & Macdonald, J. A. (2023). Associations between maternal psychological distress and mother-infant bonding: a systematic review and meta-analysis. *Archives of Women's Mental Health*, 26(4), 441–452. <https://doi.org/10.1007/s00737-023-01332-1>
- Pawłowski, B., Madej, A., Haczkur-Pawłowska, K., Jasiński, K., Kowal, A., Malczewska, J., Fiszer, K., Łomża-Łaba, A., Dziurda, S., & Jama, G. (2024). The role of physical activity, diet, and stress management in maternal and infant health during pregnancy. *Quality in Sport*, 27, 55224. <https://doi.org/10.12775/QS.2024.27.55224>
- Permatasari, A. S., & Dewi, R. K. (2023). Pengaruh Labor Dance Terhadap Kecemasan Selama Persalinan. *Jurnal Ilmiah The Shine (Juliene)*, 9(1), 11–18.
- Pino, O., Di Pietro, S., & Poli, D. (2023). Effect of Musical Stimulation on Placental Programming and Neurodevelopment Outcome of Preterm Infants: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2718. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032718>

- Puji Lestari, Y., & Friscila, I. (2023). Prenatal Yoga terhadap Tingkat Kesehatan Mental Ibu Hamil. *Media Informasi*, 19(1), 90–97. <https://ejurnal2.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/bmi>
- Radoš, S. N., Akik, B. K., Žutić, M., Rodriguez-Muñoz, M. F., Uriko, K., Motrico, E., Moreno-Peral, P., Apter, G., & den Berg, M. L. (2024). Diagnosis of peripartum depression disorder: A state-of-the-art approach from the COST Action Riseup-PPD. *Comprehensive Psychiatry*, 130, 152456. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2024.152456>
- Rezaie-Keikhaie, K., Arbabshastan, M. E., Rafiemanesh, H., Amirshahi, M., Ostadkelayeh, S. M., & Arbabisarjou, A. (2020). Systematic Review and Meta-Analysis of the Prevalence of the Maternity Blues in the Postpartum Period. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 49(2), 127–136. <https://doi.org/10.1016/j.jogn.2020.01.001>
- Salari, N., Mohammadi, A., Hemmati, M., Hasheminezhad, R., Kani, S., Shohaimi, S., & Mohammadi, M. (2023). The global prevalence of low back pain in pregnancy: a comprehensive systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-023-06151-x>
- Sánchez-Polán, M., Franco, E., Silva-José, C., Gil-Ares, J., Pérez-Tejero, J., Barakat, R., & Refoyo, I. (2021). Exercise During Pregnancy and Prenatal Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Physiology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.640024>
- Sari, D. N., Diatri, H., Siregar, K., & Pratomo, H. (2021). Adaptation of the edinburgh postnatal depression scale in the indonesian version: Self-reported anxiety and depression symptoms in pregnant women. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 1654–1659. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7783>
- Sinta, L., Endang, Z., & Surjaningrum, R. (2025). *Hubungan antara Paritas, Usia, dan Tingkat pendidikan dengan Risiko Depresi Antenatal pada Ibu Hamil di Situbondo.*

- Situmorang, R. Br., Rossita, T., & Rahmawati, D. T. (2020). Hubungan Senam Prenatal Yoga dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester III. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(03), 178–183. <https://doi.org/10.33221/jikm.v9i03.620>
- Song, B., Wang, D., Yan, X., Yan, P., Liu, H., Li, H., & Yi, S. (2024). Physical activity and sleep quality among pregnant women during the first and second trimesters are associated with mental health and adverse pregnancy outcomes. *BMC Women's Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03126-8>
- Sri, W. (2024). Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Kejadian Depresi Postpartum di Kabupaten Bantul Yogyakarta. *JURNAL ILMU KESEHATAN MULIA MADANI YOGYAKARTA*, 5(1), 69–75.
- Sulistyorini, Y., Mahmudah, M., & Puspitasari, N. (2023). Peningkatan Kemampuan Deteksi Dini Depresi pada Ibu Hamil di Kota Surabaya. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 469–476. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i3.4469>
- Sun, J., Piernicka, M., Worska, A., & Szumilewicz, A. (2023). A socio-ecological model of factors influencing physical activity in pregnant women: a systematic review. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1232625>
- Thomason, M. E., & Hendrix, C. L. (2024). Prenatal Stress and Maternal Role in Neurodevelopment. *Annual Review of Developmental Psychology*, 6(1), 87–107. <https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-120321-011905>
- Toberna, C. P., Horter, D., Heslin, K., Forgie, M. M., Malloy, E., & Kram, J. J. F. (2020). Dancing During Labor: Social Media Trend or Future Practice? *Journal of Patient-Centered Research and Reviews*, 7(2), 213–217. <https://doi.org/10.17294/2330-0698.1723>

- Tosto, V., Ceccobelli, M., Lucarini, E., Tortorella, A., Gerli, S., Parazzini, F., & Favilli, A. (2023). Maternity Blues: A Narrative Review. *Journal of Personalized Medicine*, 13(1), 154. <https://doi.org/10.3390/jpm13010154>
- Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum. (2023). *Obstetrics & Gynecology*, 141(6), 1262–1288. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000005202>
- Tri Rahayu, F., & Feriani, P. (2025). Hubungan Kepribadian dengan Tingkat Depresi Ibu Postpartum di Puskesmas Trauma Center Samarinda. *Borneo Student Research*, 2(1), 2020.
- Valdes, E. G., Sparkman, L., Aamar, R., Steiner, L., Gorman, J. M., Ittel, V., Bethea, J. J., & Reist, C. (2023). Improving maternal mental health: assessing the extent of screening and training about peripartum depression. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 36(1). <https://doi.org/10.1080/14767058.2022.2155042>
- Van den Bergh, B. R. H., Dahnke, R., & Mennes, M. (2019). Prenatal stress and the developing brain: Risks for neurodevelopmental disorders — ERRATUM. *Development and Psychopathology*, 31(1), 395–395. <https://doi.org/10.1017/S0954579418001402>
- Veftisia, V., & Afriyani, L. D. (2021). Tingkat Kecemasan, Stress Dan Depresi Pada Ibu Hamil Trimester II Dan III di PMB Ibu Alam Kota Salatiga. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.35473/ijm.v4i1.893>
- Vitania, W., & Astutik, E. D. W. (2025). Effectiveness of Dance Pregnancy Modification on Improving Depression Levels in High-Risk Pregnant Women. *Jurnal Ners*, 9(2), 1496–1503.
- Wang, X., Arafa, A., Liu, K., Eshak, E. S., Hu, Y., & Dong, J.-Y. (2021). Combined healthy lifestyle and depressive symptoms: a meta-analysis of observational studies. *Journal of Affective Disorders*, 289, 144–150. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.04.030>

- Yang, S.-Y., Lan, S.-J., Yen, Y.-Y., Hsieh, Y.-P., Kung, P.-T., & Lan, S.-H. (2020). Effects of Exercise on Sleep Quality in Pregnant Women: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Asian Nursing Research*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.anr.2020.01.003>
- Yavaş, K., & Kırca, A. Ş. (2025). The effect of dance and massage applied by spouses during childbirth on labor pain, comfort, and satisfaction. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 305, 305–311. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.12.031>
- Zacher Kjeldsen, M.-M., Bricca, A., Liu, X., Frokjaer, V. G., Madsen, K. B., & Munk-Olsen, T. (2022a). Family History of Psychiatric Disorders as a Risk Factor for Maternal Postpartum Depression. *JAMA Psychiatry*, 79(10), 1004. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.2400>
- Zacher Kjeldsen, M.-M., Bricca, A., Liu, X., Frokjaer, V. G., Madsen, K. B., & Munk-Olsen, T. (2022b). Family History of Psychiatric Disorders as a Risk Factor for Maternal Postpartum Depression. *JAMA Psychiatry*, 79(10), 1004. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.2400>
- Zhang, L., Yue, R., Xiao, F., Wang, F., & Zhang, Z. (2025). The effects of dance on maternal childbirth: a systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1), 20. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-07132-4>
- Zhu, Y., Wang, R., Tang, X., Li, Q., Xu, G., & Zhang, A. (2021). The effect of music, massage, yoga and exercise on antenatal depression: A meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 292, 592–602. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.05.122>

Glosarium

A

Aktivitas Fisik: Gerakan tubuh yang meningkatkan energi, seperti berjalan, menari, atau latihan ringan, yang bermanfaat untuk kesehatan ibu hamil.

Arm Circle: Gerakan memutar lengan secara perlahan untuk meningkatkan fleksibilitas bahu dan sirkulasi darah.

B

Baby Down: Gerakan dalam *Pregnancy Dance* yang membantu posisi janin turun ke panggul, mempersiapkan persalinan.

Back Squat: Latihan jongkok dengan beban di punggung atas; pada ibu hamil, dilakukan tanpa beban untuk memperkuat otot paha dan panggul.

Body Awareness: Kesadaran terhadap posisi dan gerakan tubuh, penting untuk menjaga postur dan keseimbangan selama kehamilan.

D

Denyut Jantung Janin: Detak jantung bayi dalam kandungan, indikator penting kesehatan janin yang dipantau selama kehamilan.

Diabetes Gestasional: Kondisi kadar gula darah tinggi yang berkembang selama kehamilan dan biasanya hilang setelah melahirkan.

Dukungan Emosional: Bantuan dari lingkungan sekitar yang memberikan kenyamanan dan keamanan emosional bagi ibu hamil.

Durasi: Lama waktu pelaksanaan aktivitas, seperti sesi *Pregnancy Dance*, yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil.

F

Fleksibilitas: Kemampuan otot dan sendi untuk bergerak bebas tanpa rasa sakit, penting untuk kenyamanan selama kehamilan.

G

Gangguan Postural: Perubahan posisi tubuh yang tidak normal, sering terjadi selama kehamilan akibat perubahan pusat gravitasi.

H

Hip Rotation 360: Gerakan memutar pinggul secara penuh, membantu meningkatkan mobilitas dan mengurangi ketegangan otot.

Hip Sway: Gerakan mengayun pinggul ke samping, bermanfaat untuk relaksasi dan memperkuat otot panggul.

Holistik: Pendekatan yang mempertimbangkan keseluruhan aspek kesehatan fisik, mental, dan emosional ibu hamil.

Hormon Relaksin: Hormon yang diproduksi selama kehamilan untuk melonggarkan ligamen dan mempersiapkan tubuh untuk persalinan.

I

Ibu Hamil Berisiko Tinggi: Wanita hamil dengan kondisi medis atau faktor lain yang meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan atau persalinan.

Instruktur: Orang yang memandu kelas *Pregnancy Dance*, sebaiknya memiliki pengetahuan tentang kehamilan dan latihan fisik yang aman.

Intensitas Gerakan: Tingkat kekuatan atau usaha dalam melakukan gerakan, disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi ibu hamil.

Insufisiensi Serviks: Kondisi di mana leher rahim melemah dan terbuka terlalu dini, meningkatkan risiko kelahiran prematur.

K

Kecemasan: Perasaan gelisah atau khawatir yang berlebihan, umum terjadi selama kehamilan dan dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin.

Kelahiran Prematur: Persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu, berisiko bagi kesehatan bayi.

Kehamilan Berisiko: Kehamilan dengan faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan komplikasi bagi ibu atau janin.

Kesejahteraan Mental: Keadaan pikiran yang sehat dan stabil, penting untuk keseimbangan emosional selama kehamilan.

Kontraindikasi Medis: Kondisi medis yang menjadi alasan untuk tidak melakukan aktivitas tertentu, seperti olahraga berat selama kehamilan.

Kontraksi Rahim: Gerakan otot rahim yang menandakan awal persalinan atau sebagai respons terhadap aktivitas fisik.

O

Obesitas: Kondisi kelebihan berat badan yang dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan.

Overheating: Kenaikan suhu tubuh yang berlebihan, dapat berbahaya bagi ibu hamil dan janin, terutama selama aktivitas fisik.

P

Pelvic Tilt: Gerakan memiringkan panggul untuk memperkuat otot perut dan punggung bawah, membantu mengurangi nyeri punggung.

Preeklamsia: Kondisi serius selama kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ, memerlukan penanganan medis segera.

Pregnancy Dance: Aktivitas tari yang dirancang khusus untuk ibu hamil, menggabungkan gerakan lembut dan musik untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental.

Progressive Overload: Prinsip peningkatan beban latihan secara bertahap untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot.

Powerful Mama: Istilah dalam *Pregnancy Dance* yang menggambarkan gerakan kuat dan penuh percaya diri, meningkatkan rasa pemberdayaan ibu hamil.

R

Rainbow Teknik: Gerakan dalam *Pregnancy Dance* yang menyerupai bentuk pelangi, melibatkan gerakan lengan dan tubuh yang melengkung untuk meningkatkan fleksibilitas.

S

Self-Paced: Pendekatan latihan di mana individu menyesuaikan kecepatan dan intensitas gerakan sesuai dengan kenyamanan dan kemampuan pribadi.

Side Step: Gerakan melangkah ke samping, membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi.

Single Step: Langkah tunggal yang digunakan dalam *Pregnancy Dance* untuk menjaga ritme dan keseimbangan.

Step Touch: Gerakan dasar dalam tari yang melibatkan langkah ke samping diikuti dengan sentuhan kaki lainnya, digunakan untuk pemanasan dan pendinginan.

Stres: Respons tubuh terhadap tekanan atau tantangan, dapat memengaruhi kesehatan ibu hamil jika tidak dikelola dengan baik.

T

Talk Test: Metode sederhana untuk mengukur intensitas latihan; jika ibu hamil dapat berbicara dengan nyaman selama aktivitas, intensitas dianggap aman.

Trimester: Pembagian masa kehamilan menjadi tiga periode masing-masing sekitar tiga bulan, digunakan untuk memantau perkembangan janin dan kesehatan ibu.

Profil Penulis



Bdn. Wiwit Vitania, S.ST., M.Keb. lahir di Surabaya pada 9 Oktober 1988. Perjalanan pendidikannya dimulai dengan menempuh jenjang D3 di Program Studi Kebidanan AKBID Jember, kemudian melanjutkan pendidikan D4 di Poltekkes Kemenkes Malang dan berhasil lulus pada tahun 2011. Kecintaannya terhadap dunia kebidanan membawanya meraih gelar Magister Kebidanan (S2) di Universitas Padjadjaran pada

tahun 2019, hingga akhirnya menyelesaikan Program Studi Profesi Bidan di STIKES Ngudia Husada Madura pada tahun 2023.

Kariernya dimulai pada tahun 2009 sebagai bidan di Bidan Praktik Mandiri dan Puskesmas. Saat ini, ia berkontribusi sebagai tenaga pengajar di Universitas Jayapura. Tak hanya aktif dalam dunia akademik, ia juga berperan dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk menulis buku, melakukan publikasi ilmiah, menghadiri seminar, serta menjalankan praktik kebidanan.

Untuk informasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email: **wiwitvitania88@gmail.com** atau **stvitania08@gmail.com**.

Motto: Ilmu dan ketulusan adalah harta sejati seorang bidan. Menjadi bidan bukan sekadar profesi, tetapi panggilan jiwa untuk terus belajar, berjuang, dan melayani dengan hati.

Profil Penulis



Eftyaningrum Dwi Wahyu Astutik, M.Tr.Keb

merupakan dosen pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura. Lahir di Malang pada tanggal 28 April 1986. Perjalanan pendidikannya dimulai dengan menempuh jenjang D3 di Program Studi Studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Media Jombang pada tahun 2005-2008. Melanjutkan pendidikan ke jenjang D4 pada tahun 2023-2024 di Program Studi D4 Kebidanan

Pendidik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Tidak berhenti sampai disitu, penulis melanjutkan pendidikan pada tahap pasca sarjana di Program Studi Magister Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2017-2020. Perjalan karir penulis diawali sebagai bidan praktisi di sebuah rumah sakit militer di Sidoarjo sebagai tim bedah kebidanan dari tahun 2008-2011. Mencoba beralih haluan menjadi bidan pendidik mulai tahun 2011 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura sebagai pembimbing praktik laboratorium kebidanan dan berlanjut menjadi dosen pengajar hingga saat ini. Tidak hanya sebagai dosen pengajar, namun penulis juga memiliki tugas tambahan dosen dalam jabatan structural sebagai Ketua Program Studi S1 Kebidanan pada tahun 2023-2024, dilanjutkan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura pada periode 2024-2025. Tidak hanya terpaku pada tugas tambahan dosen, namun penulis juga aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang dosen. Untuk informasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email: **eft.princes@gmail.com**

Motto: Ikhlas Dalam Menjalani Segala Sesuatu adalah Tabungan Emas Tak Berbentuk Yang Akan Dipetik Jika Allah Sudah Mengizinkannya.

Profil Penulis



Yustika Rahmawati Pratami, S.Tr.Keb., M.Keb. lahir di Arso 7 Oktober 1996. Penulis menempuh pendidikan Diploma IV Kebidanan ditempuh di Poltekkes Kemenkes Jayapura, lulus tahun 2018 dan S2 Kebidanan tahun 2019 di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Sejak Januari 2022-Juni 2022 bekerja di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke sebagai dosen tetap.

Selanjutnya sejak 15 Juli 2022 menjadi dosen dosen tetap di Prodi SI Kebidanan di STIKES Jayapura sampai saat ini. Penulis dapat dihubungi melalui email: yustikarahmawati068@gmail.com.

Motto: Jangan berani bertanya sebelum anda banyak membaca.

SINOPSIS BUKU

Buku ini menyajikan pendekatan inovatif dalam mendukung kesehatan mental ibu hamil melalui praktik *Pregnancy Dance*, sebuah bentuk terapi gerak yang menggabungkan elemen fisik, emosional, dan spiritual. Dengan mengintegrasikan gerakan ritmis, pernapasan sadar, dan musik yang menenangkan, *Pregnancy Dance* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tubuh, memperkuat koneksi emosional antara ibu dan janin, serta mengurangi gejala depresi dan kecemasan yang umum terjadi selama kehamilan.

Penelitian menunjukkan bahwa terapi gerak seperti *Dance Movement Therapy* (DMT) efektif dalam menurunkan tingkat depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan interpersonal. Selain itu, DMT juga dapat meningkatkan kesadaran tubuh dan citra diri, yang penting bagi ibu hamil dalam menghadapi perubahan fisik dan emosional selama kehamilan.

Buku ini juga menyoroti pentingnya aspek spiritual dalam *Pregnancy Dance*, dimana gerakan meditatif dan reflektif membantu ibu hamil mengolah pengalaman kehamilan secara mendalam, mengurangi tekanan psikologis, dan memperkuat identitas sebagai calon ibu. Dengan pendekatan holistik, *Pregnancy Dance* tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai sarana terapi yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional ibu hamil.

Ditujukan bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan ibu hamil, buku ini menawarkan panduan praktis dan berbasis bukti ilmiah dalam menerapkan *Pregnancy Dance* sebagai bagian dari perawatan prenatal. Melalui sinergi antara gerakan, musik, dan kesadaran diri, pembaca diajak untuk mengeksplorasi potensi terapi gerak dalam menciptakan pengalaman kehamilan yang lebih sehat dan bermakna.

Buku ini menyajikan pendekatan inovatif dalam mendukung kesehatan mental ibu hamil melalui praktik Pregnancy Dance, sebuah bentuk terapi gerak yang menggabungkan elemen fisik, emosional, dan spiritual. Dengan mengintegrasikan gerakan ritmis, pernapasan sadar, dan musik yang menenangkan, Pregnancy Dance bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tubuh, memperkuat koneksi emosional antara ibu dan janin, serta mengurangi gejala depresi dan kecemasan yang umum terjadi selama kehamilan.

Penelitian menunjukkan bahwa terapi gerak seperti Dance Movement Therapy (DMT) efektif dalam menurunkan tingkat depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan interpersonal. Selain itu, DMT juga dapat meningkatkan kesadaran tubuh dan citra diri, yang penting bagi ibu hamil dalam menghadapi perubahan fisik dan emosional selama kehamilan.

Buku ini juga menyoroti pentingnya aspek spiritual dalam Pregnancy Dance, dimana gerakan meditatif dan reflektif membantu ibu hamil mengolah pengalaman kehamilan secara mendalam, mengurangi tekanan psikologis, dan memperkuat identitas sebagai calon ibu. Dengan pendekatan holistik, Pregnancy Dance tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai sarana terapi yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional ibu hamil.

Ditujukan bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan ibu hamil, buku ini menawarkan panduan praktis dan berbasis bukti ilmiah dalam menerapkan Pregnancy Dance sebagai bagian dari perawatan prenatal. Melalui sinergi antara gerakan, musik, dan kesadaran diri, pembaca diajak untuk mengeksplorasi potensi terapi gerak dalam menciptakan pengalaman kehamilan yang lebih sehat dan bermakna.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89972-5-1



9

786238

997251